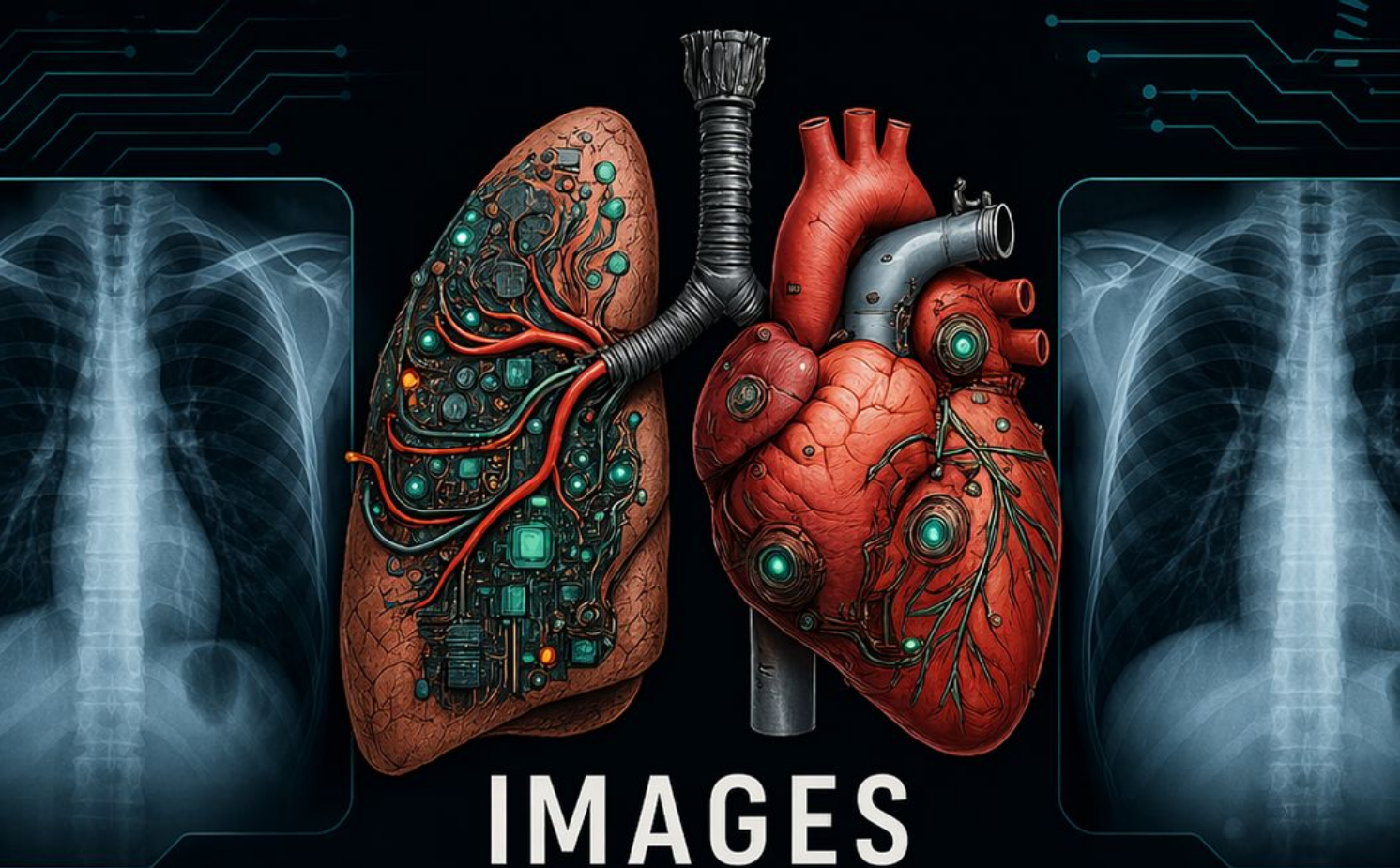




IMAGES RADIOLOGIQUES PULMONAIRES

SECONDAIRES À UNE
PATHOLOGIE CARDIAQUE



Dr HOURI
Pneumologue



PRÉSENTÉ PAR :
Dr HOURI



SPÉCIALITÉ :
Pneumologie



DATE : _____



ANNÉE UNIVERSITAIRE : _____



1-CARDIOME GALIE

1-CARDIOMEGALIE:

La cardiomégalie est une augmentation de la taille du cœur, généralement appréciée sur une radiographie thoracique de face.



Définition radiologique:

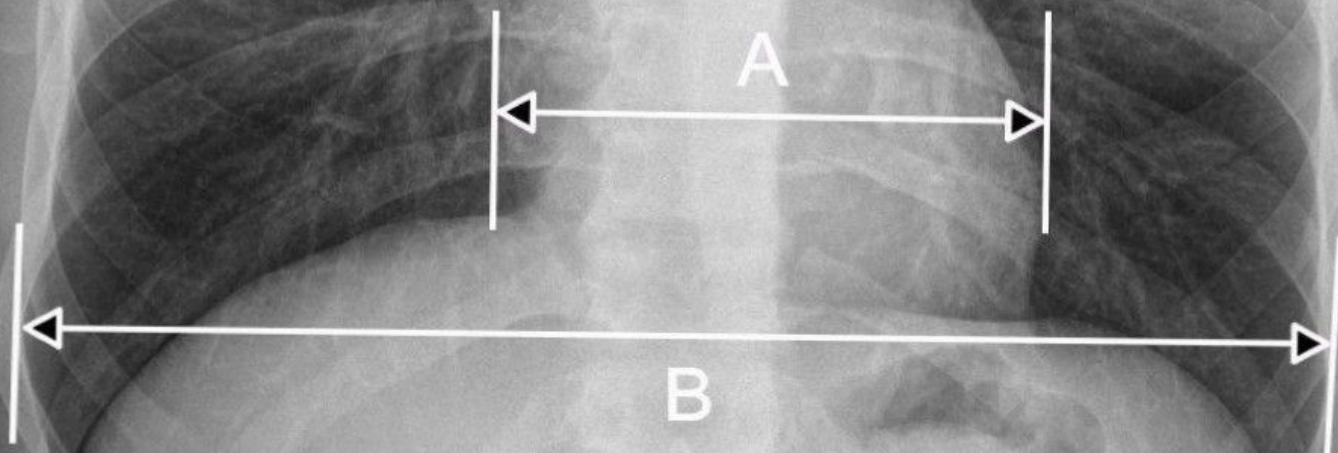


On parle de cardiomégalie si :
 $ICT > 0,5$ sur une radio de thorax
de face (prise en inspiration,
incidence postéro-antérieure)

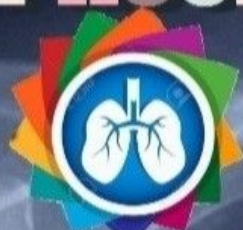
indice Cardio-thoracique

ICT:

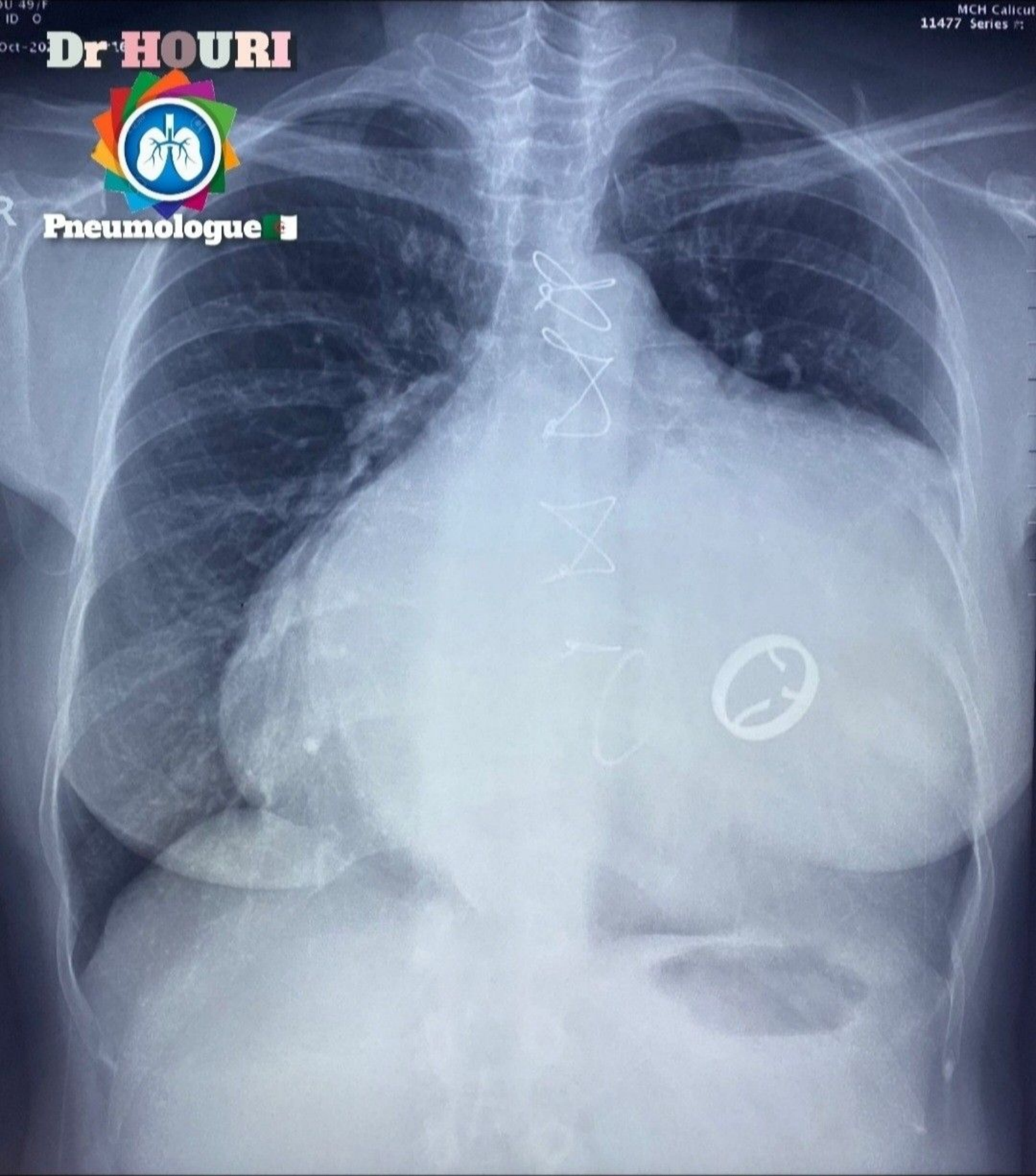
$$A/B \leq 0.5$$



Dr HOURI



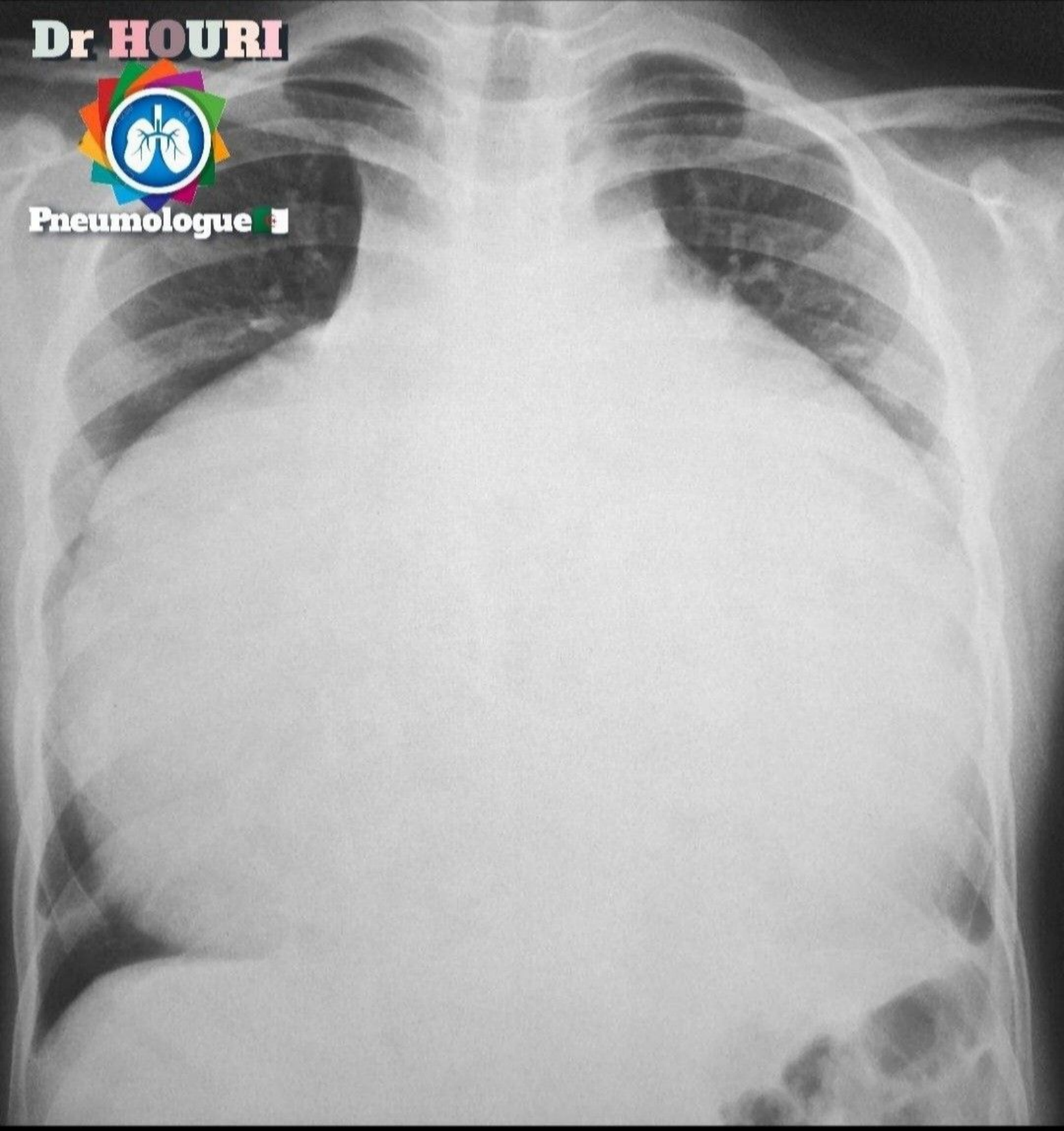
Pneumologue



Dr HOURI



Pneumologue

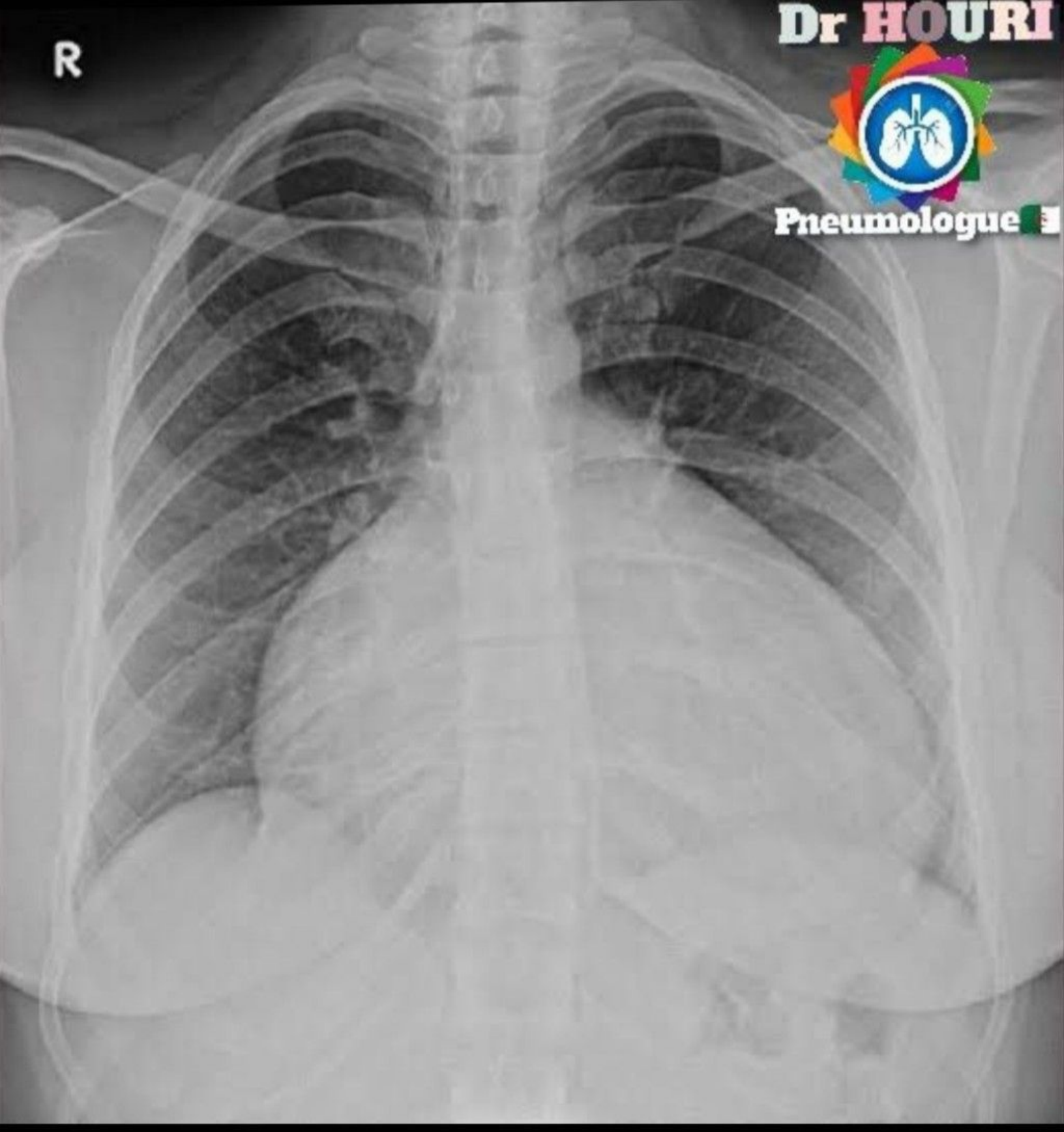


R

Dr HOURI



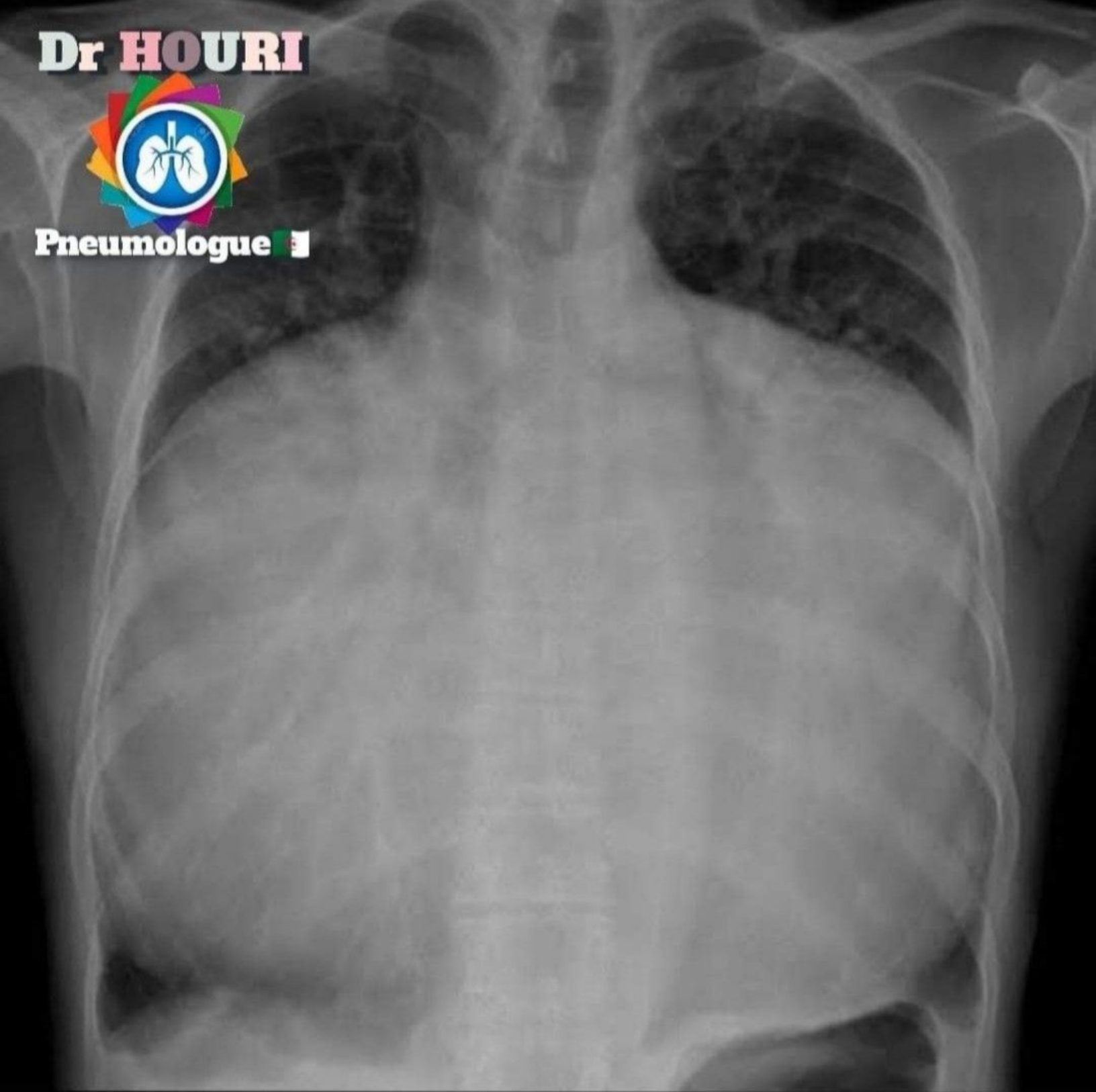
Pneumologue



Dr HOURI



Pneumologue 



2-ÉPANCHEMENT PLEURAL LIQUIDIEN BILATÉRAL

2-ÉPANCHEMENT PLEURAL LIQUIDIEN BILATÉRAL :

L'épanchement pleural liquidien bilatéral d'origine cardiaque est une manifestation fréquente de l'insuffisance cardiaque congestive, en particulier lorsque la défaillance du ventricule droit est prédominante ou associée à une insuffisance gauche sévère.



Caractéristiques typiques :

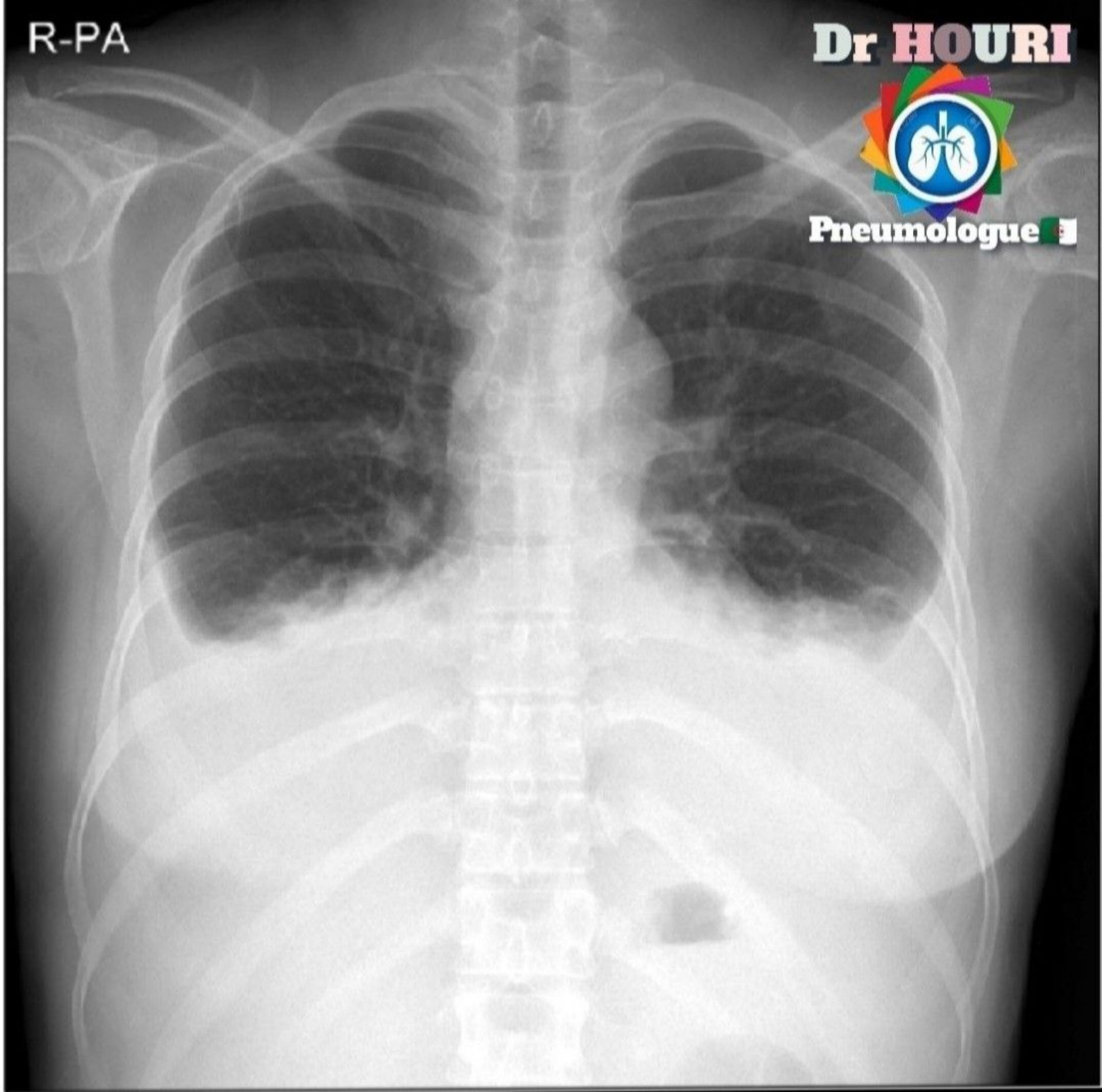
- Épanchement transsudatif (faible taux de protéines, LDH bas).
- Prédominance souvent droite en imagerie, mais l'atteinte bilatérale est fréquente (un tiers des cas).
- Souvent associé à des signes d'hypervolémie : œdèmes des membres inférieurs, turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, crépitants pulmonaires.

R-PA

Dr HOURI



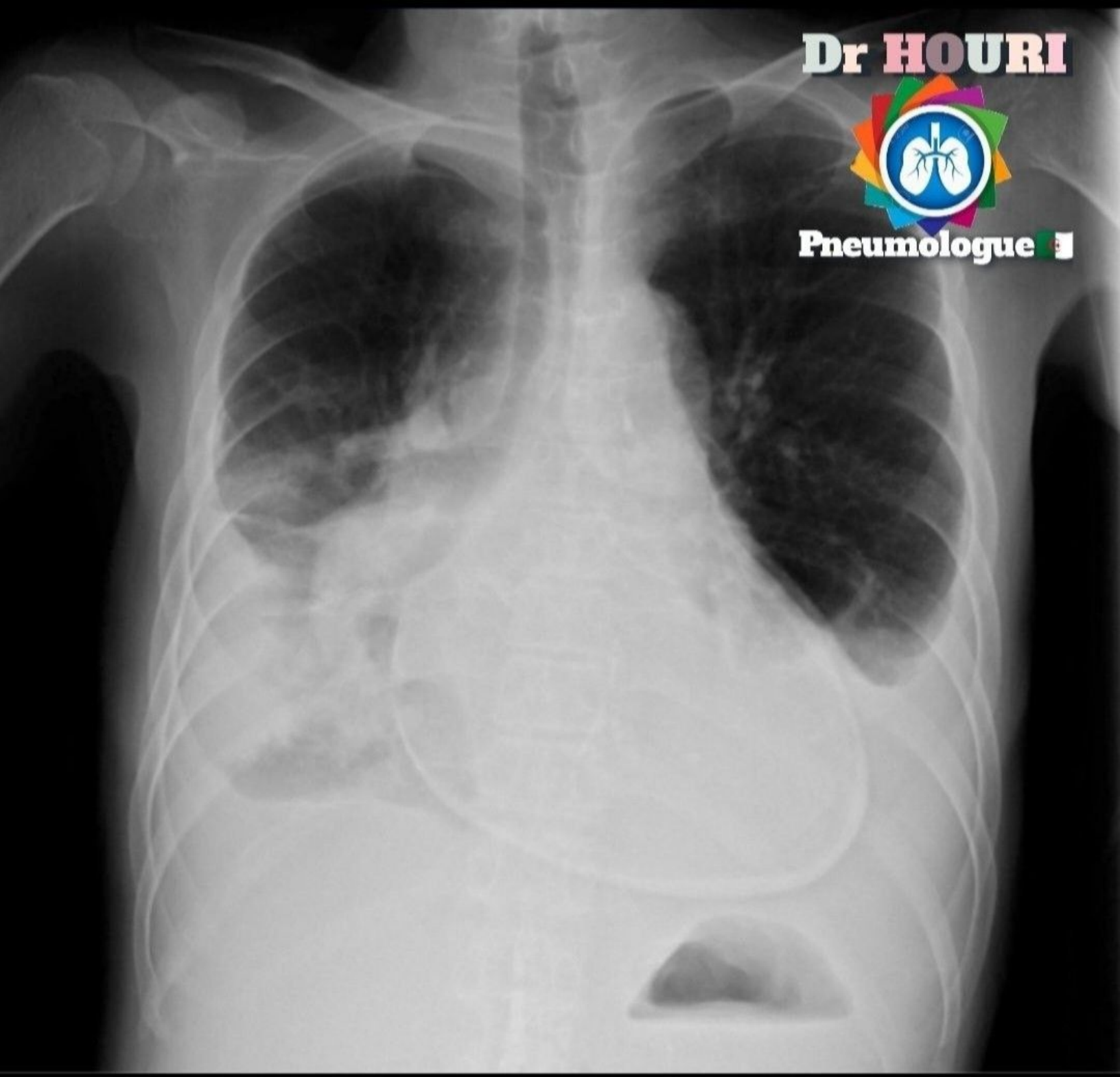
Pneumologue 



Dr HOURI



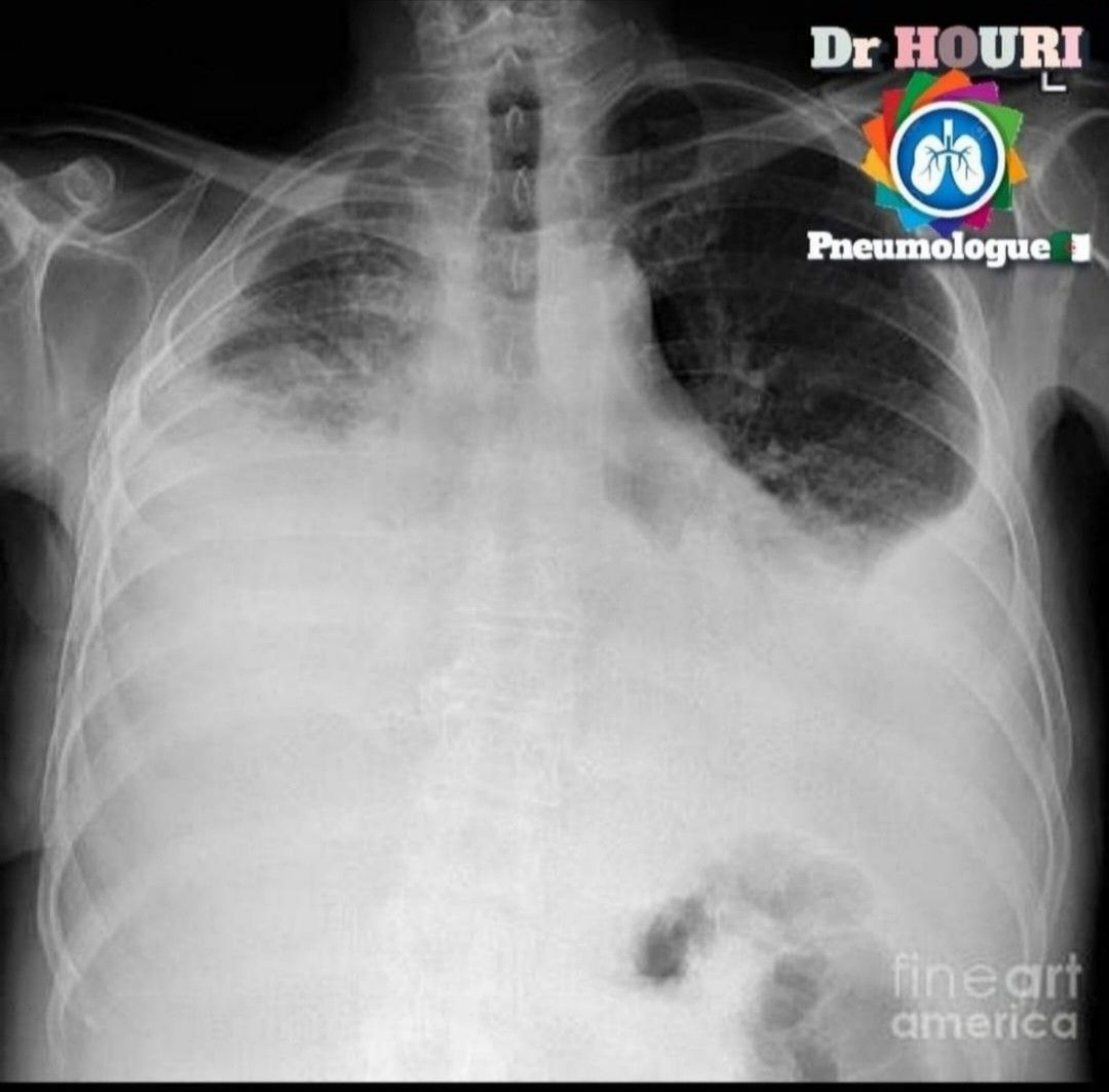
Pneumologue 



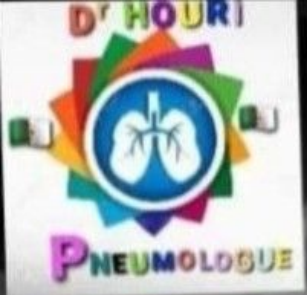
Dr HOURI



Pneumologue



fineart
america

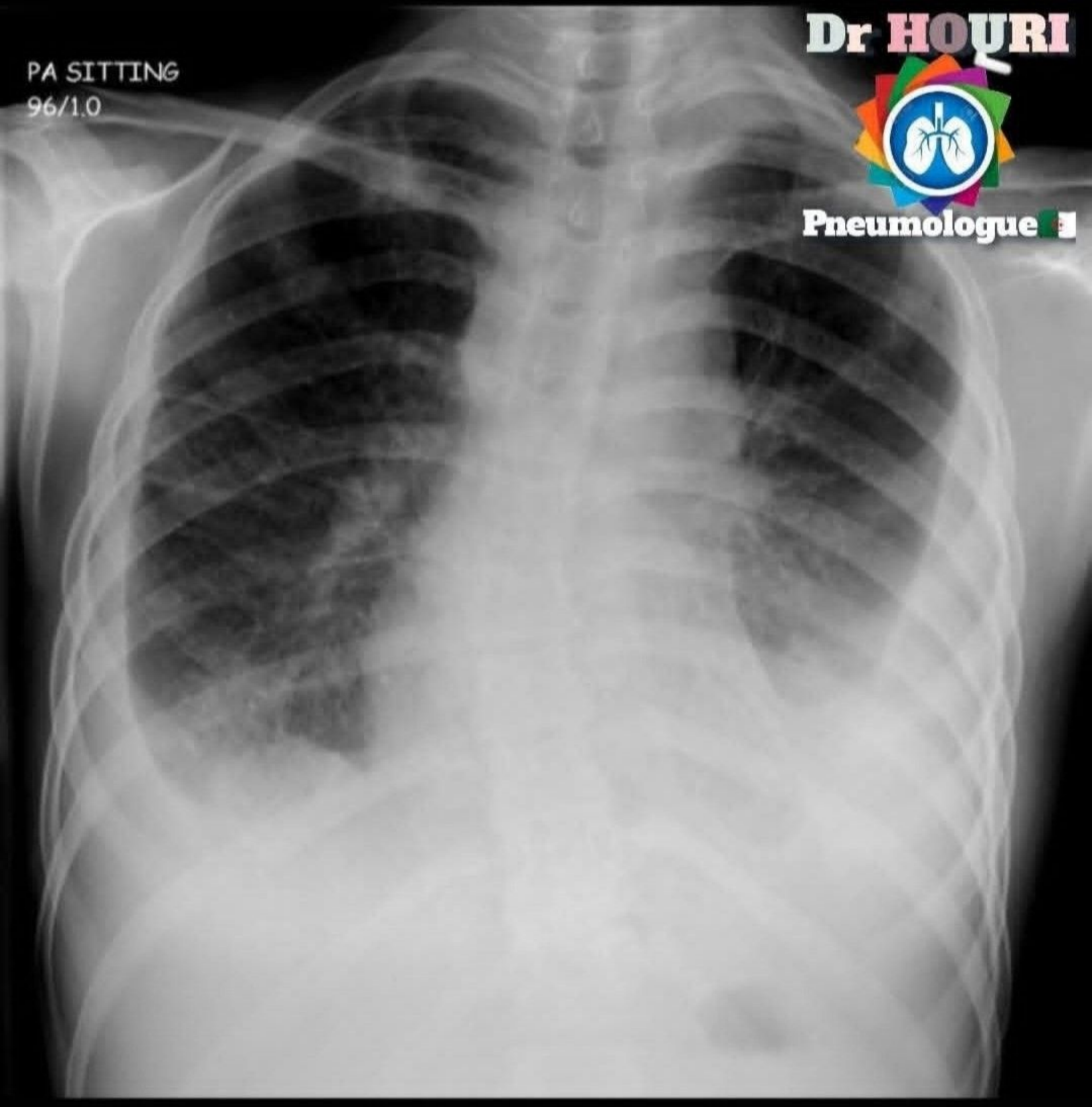


PA SITTING
96/1.0

Dr HOURI



Pneumologue



3- ŒDÈME AIGÜE DU POUMON OAP :

3- ŒDÈME AIGÛE DU POUMON OAP :

L'œdème aigu du poumon (OAP) est une inondation rapide des alvéoles pulmonaires par du liquide, le plus souvent due à une insuffisance cardiaque gauche, entraînant une détresse respiratoire aiguë.



“Ailes de papillon” – Définition radiologique

L'aspect en “ailes de papillon” correspond à :

- ➔ Des opacités alvéolaires bilatérales, symétriques, floues, à prédominance péri-hilaire,
- ➔ s'étendant vers les deux champs pulmonaires,
- ➔ réalisant une image en forme d'ailes de papillon sur la radiographie thoracique.

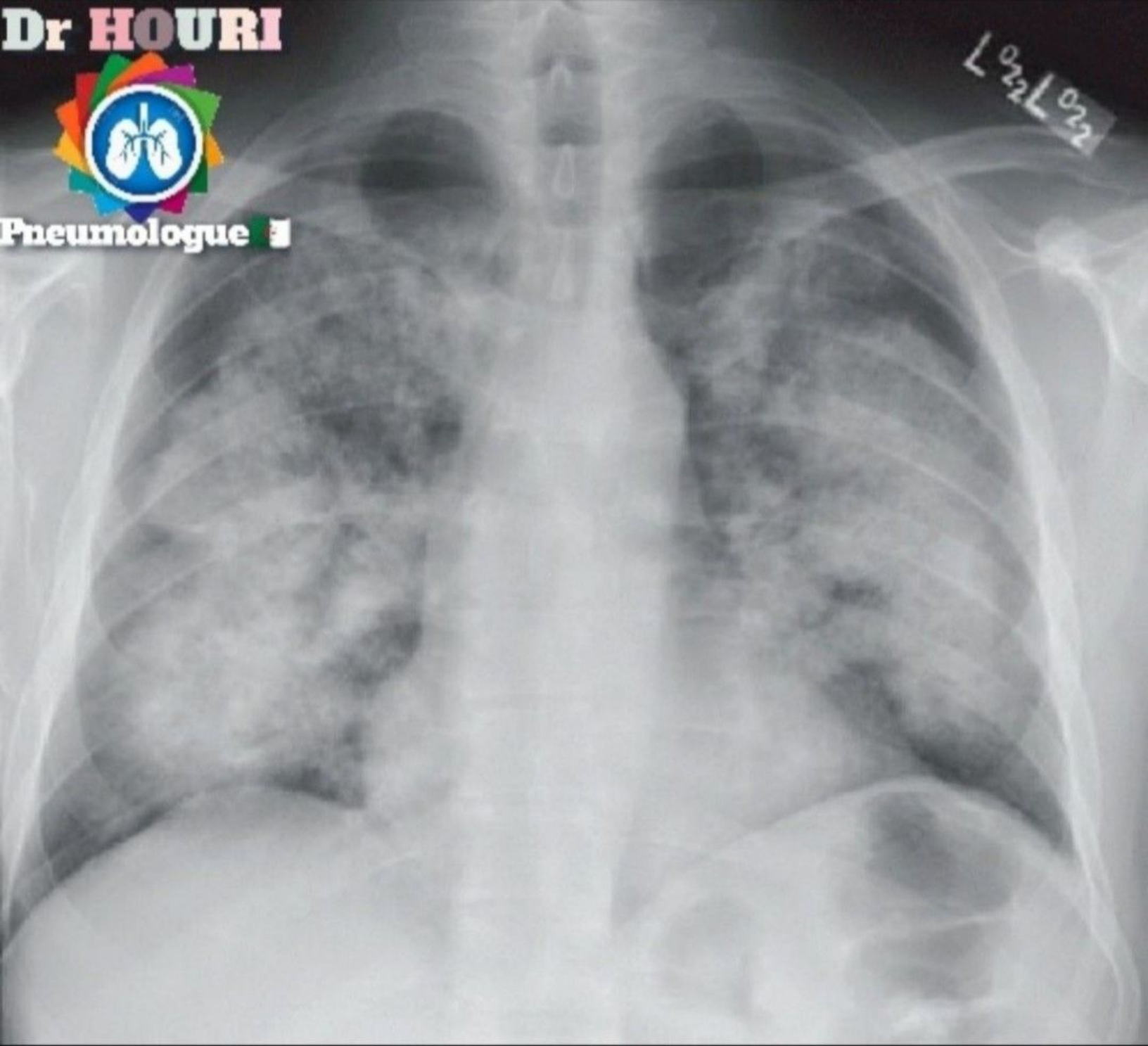


Dr HOURI



Pneumologue

L₂L₂



Dr HOURI



ERECT

OBILE

HDU

Pneumologue

Dr. HOUARI

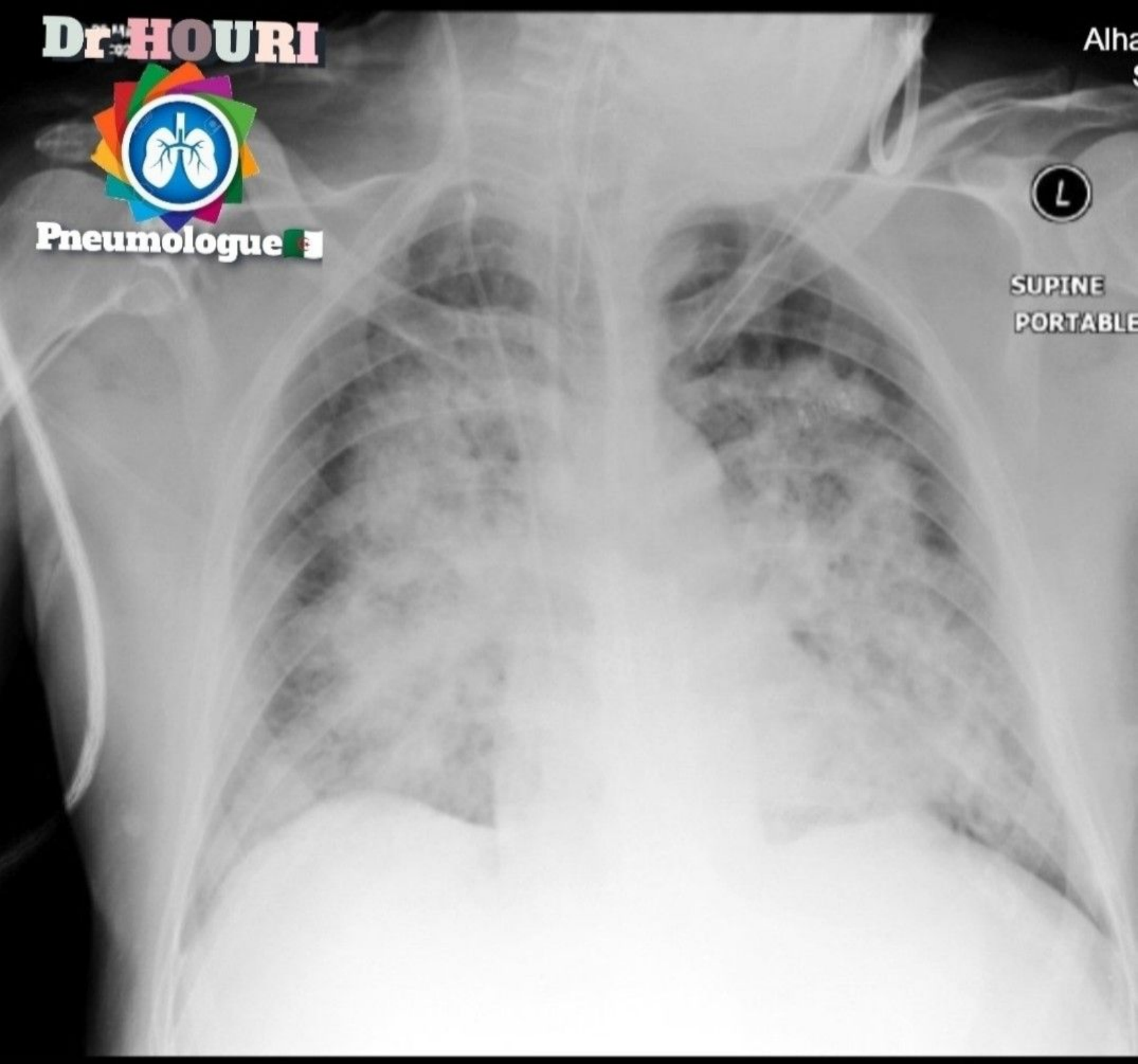


Pneumologue

Alha



SUPINE
PORTABLE



4-ANÉVRISME VENTRICULAIRE

4-ANÉVRISME VENTRICULAIRE :

est une complication grave survenant le plus souvent après un infarctus du myocarde étendu (généralement de la face antérieure). Il s'agit d'une poche fibreuse qui se forme sur la paroi du ventricule gauche, là où le muscle cardiaque nécrosé a été remplacé par du tissu cicatriciel non contractile.

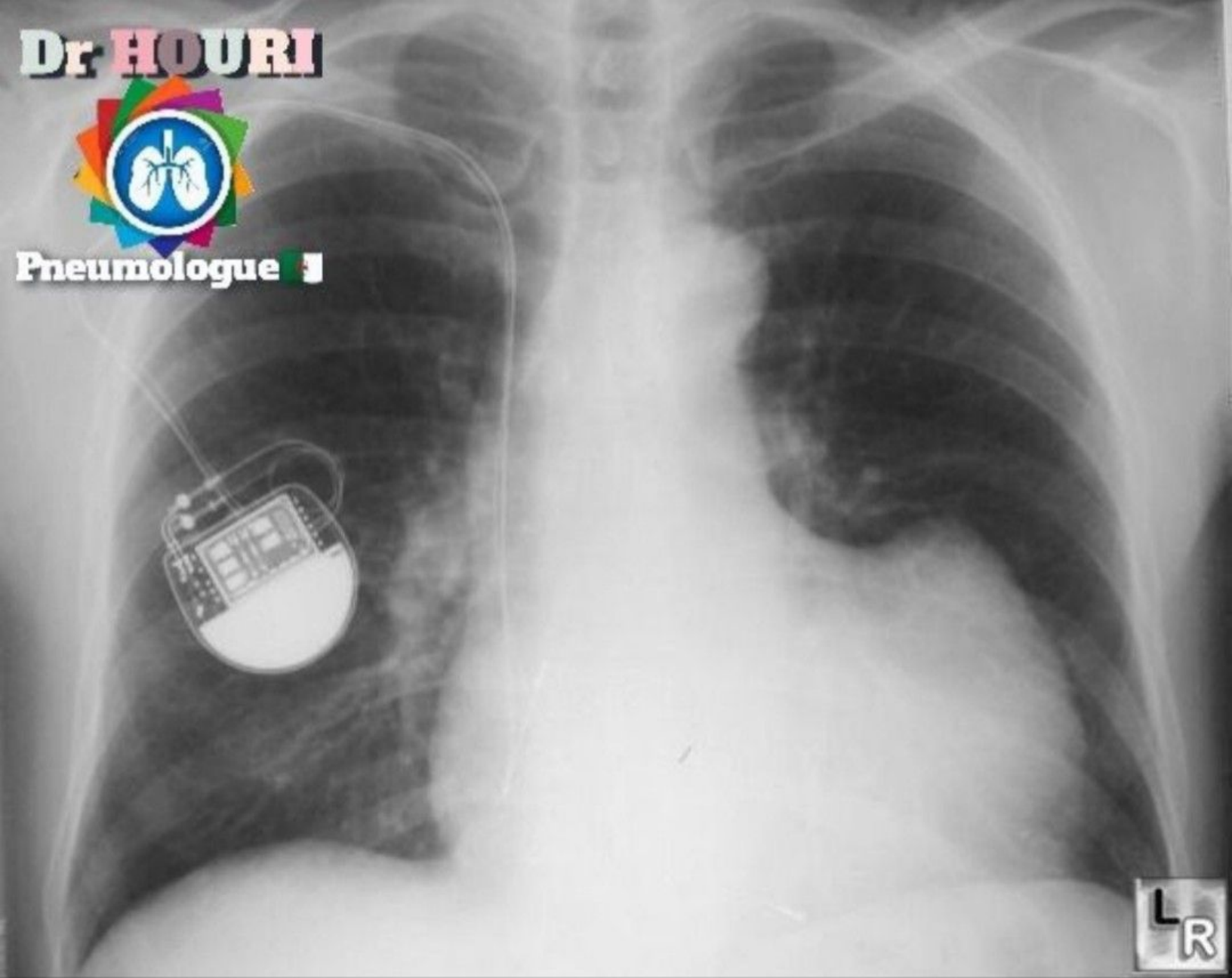
■ Sur une radiographie thoracique standard (face et profil), l'anévrisme ventriculaire gauche se manifeste par des signes souvent discrets mais évocateurs dans les formes volumineuses:

- Bourgeon ventriculaire gauche
 - Aspect en « cœur de carafe »
 - Cardiomégalie localisée
- cœur asymétrique avec déformation localisée.
- Bombement du contour ventriculaire
 - Calcifications pariétales (ancien anévrisme)

Dr HOURI



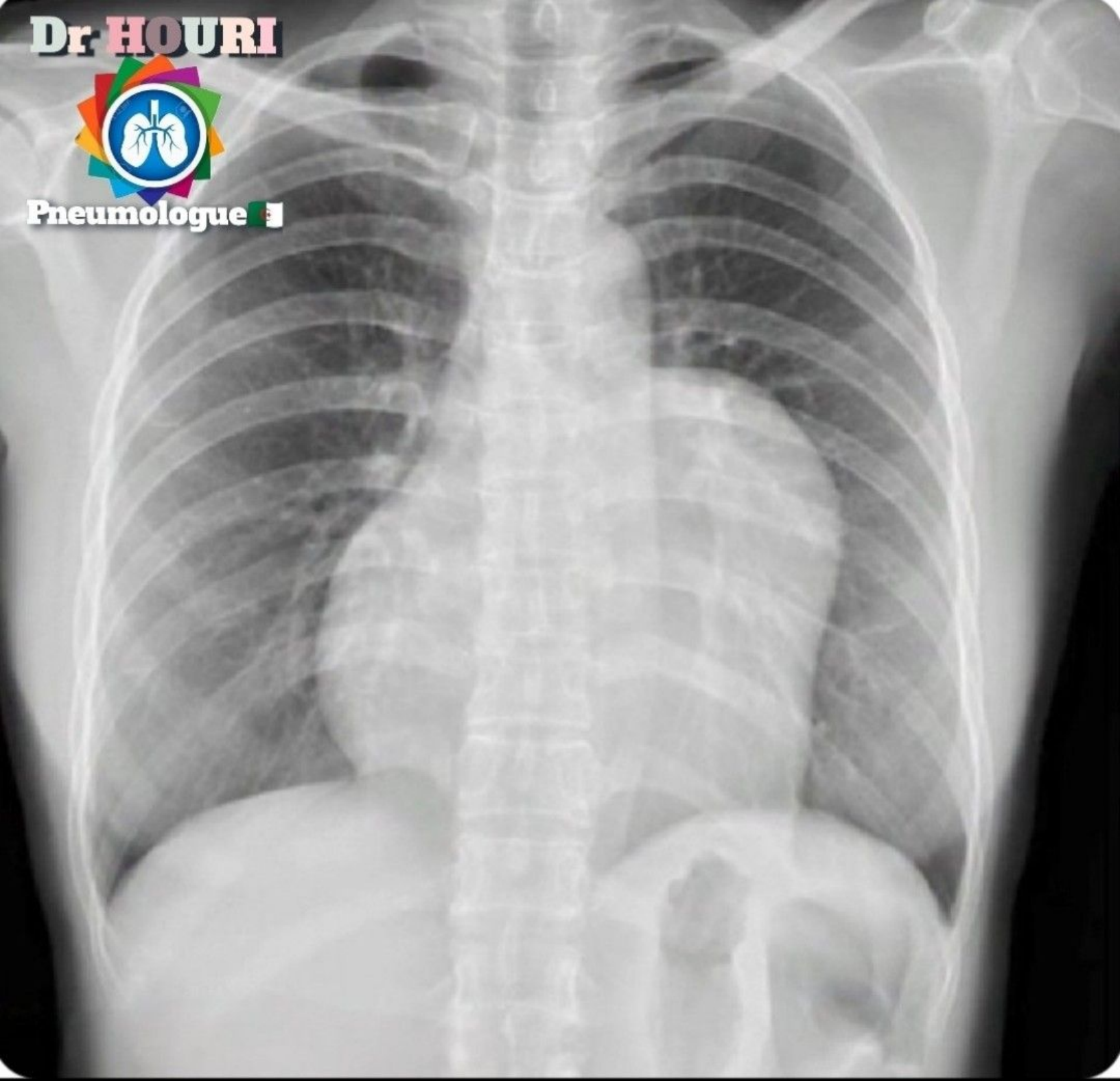
Pneumologue

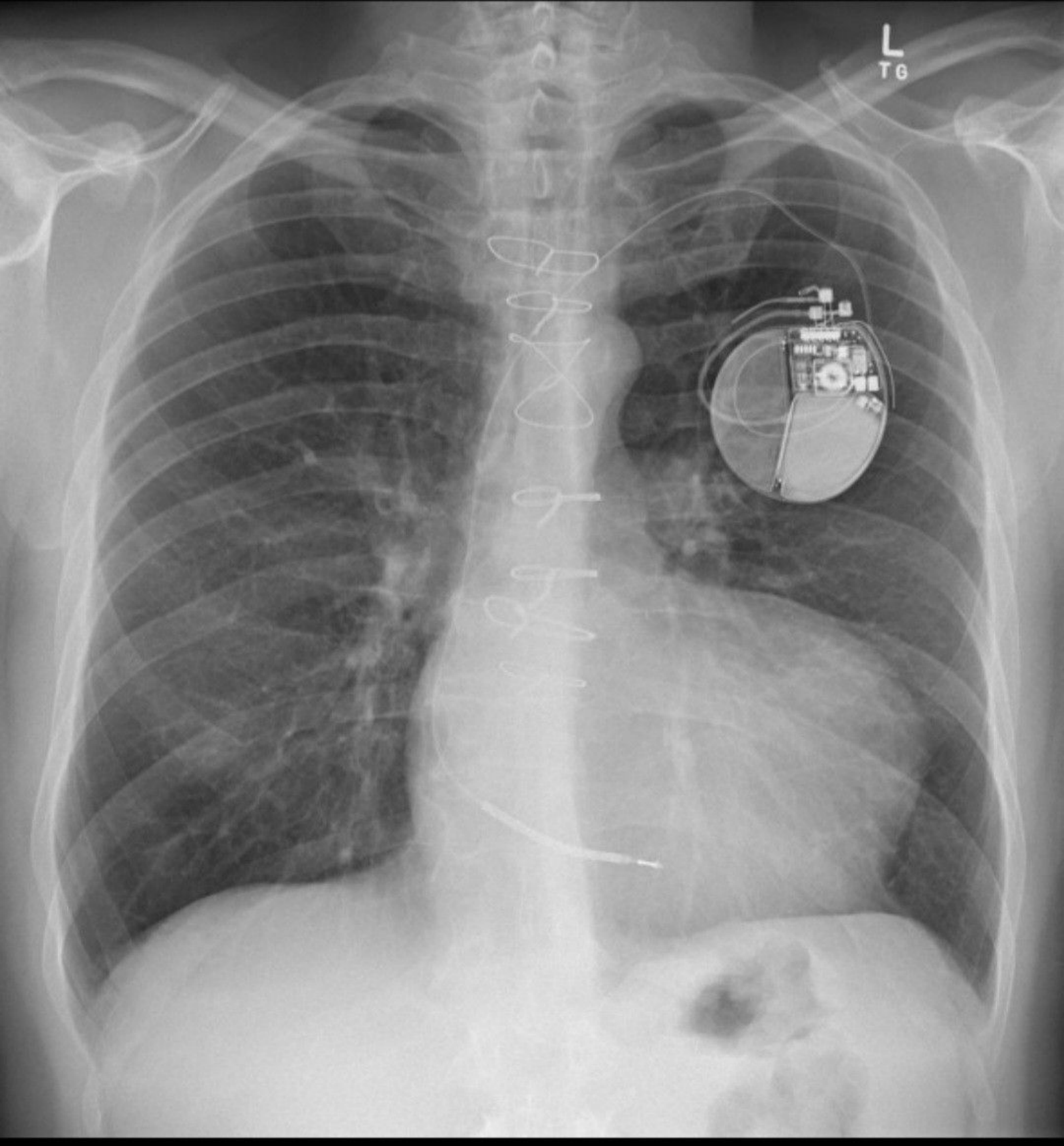


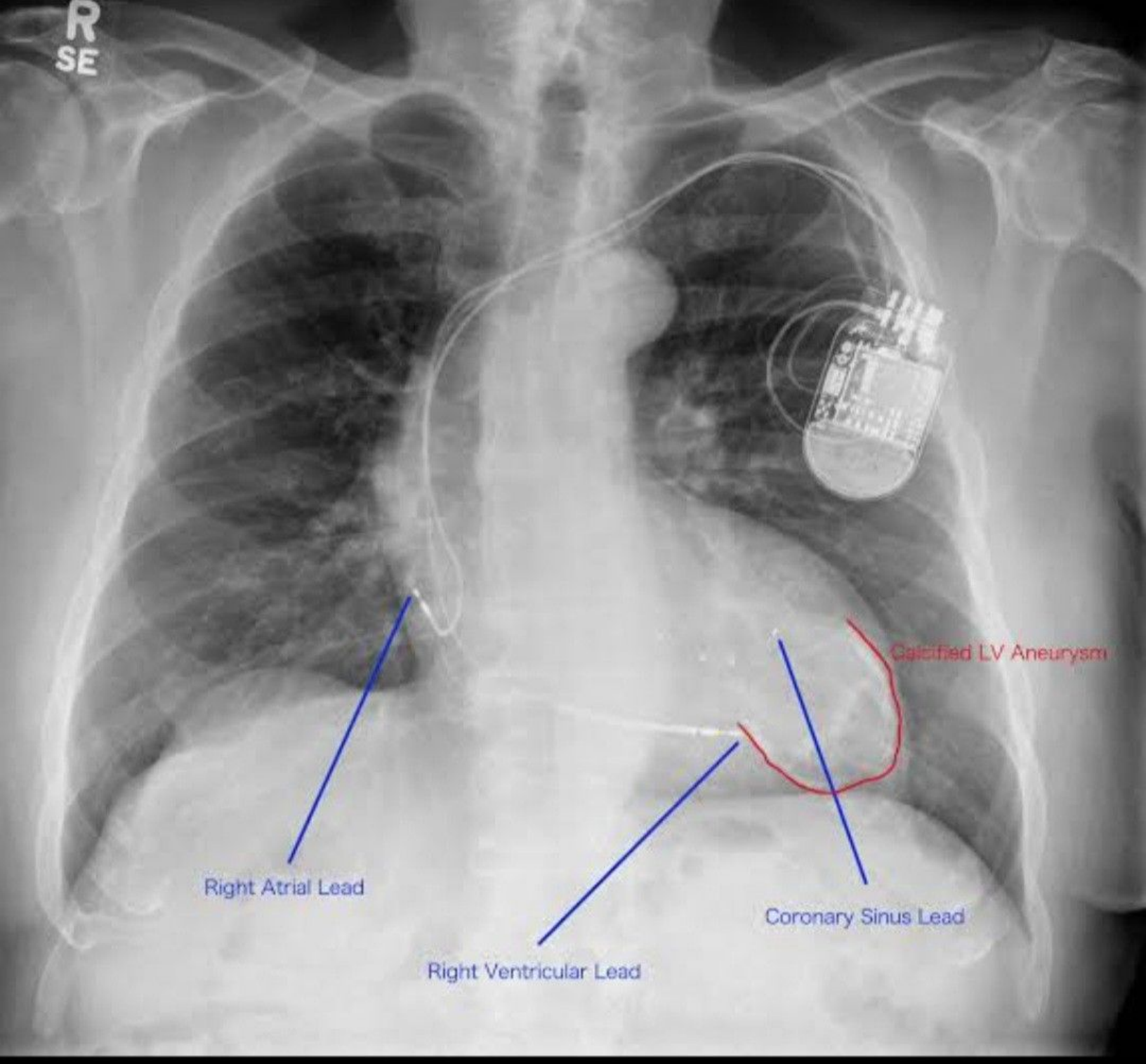
Dr. HOURI



Pneumologue 



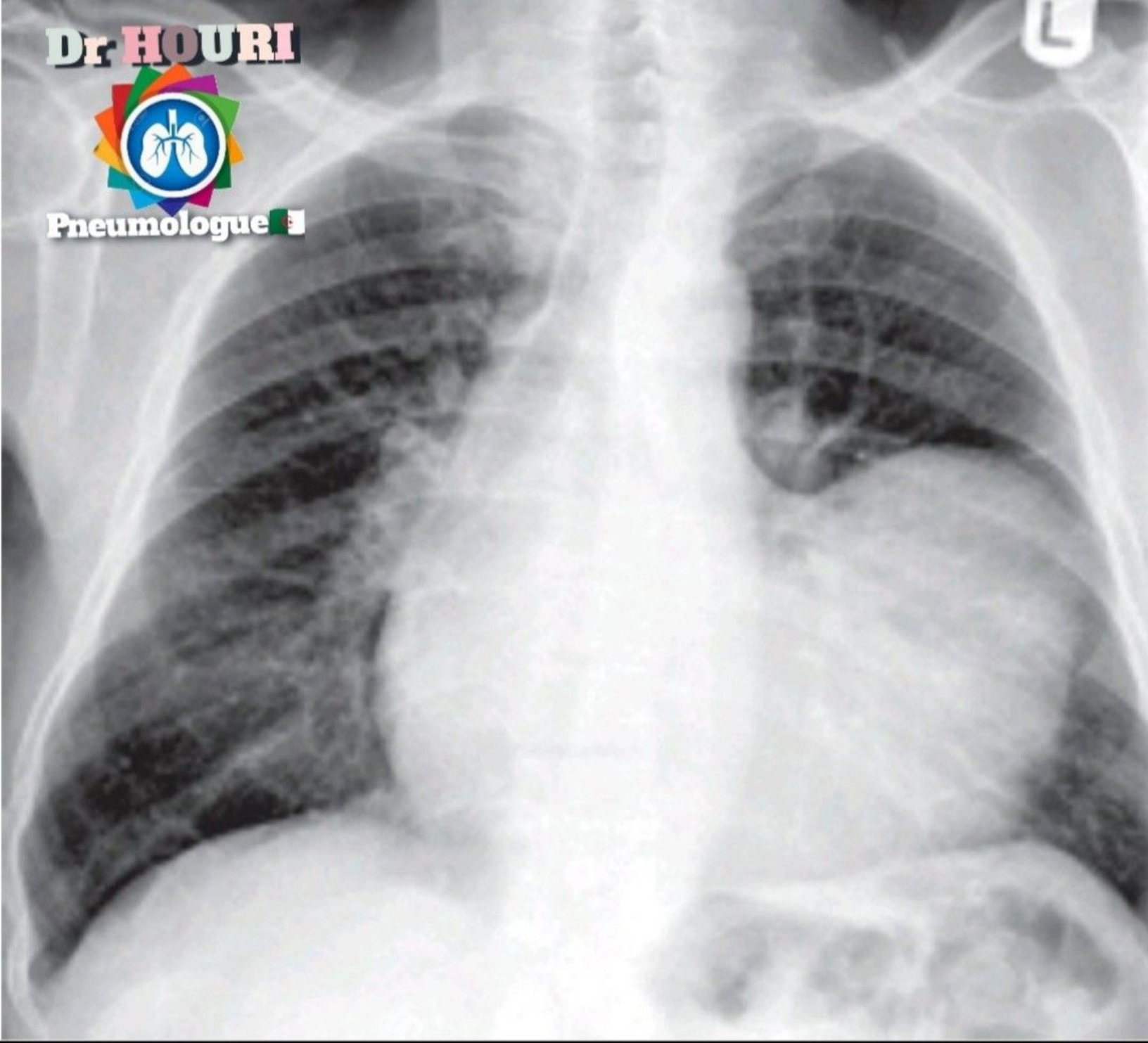




Dr HOURI



Pneumologue 



5-TUMEUR FANTÔME OU
ÉPANCHEMENT INTERLOBAIRE

5-TUMEUR FANTÔME OU ÉPANCHEMENT INTERLOBAIRE:

- ◆ Opacité ronde parahilaire droite bien limitée associée à une cardiomégalie.

Diagnostic :un épanchement interlobaire (la petite scissure).

- ◆ Les tumeurs fantômes sont des pleurésies interlobaires mimant des images radiologiques de tumeurs.

- ◆ Ces images disparaissent de temps à autre sous diurétiques (#Lasilix).

- ◆ Ce sont des épanchements de diagnostic difficile et constitue souvent une source d'erreur diagnostic.

- ◆ Dans la majorité des cas, ces tumeurs rentrent dans les signes congestifs d'une insuffisance cardiaque décompensée.

Dr HOURI



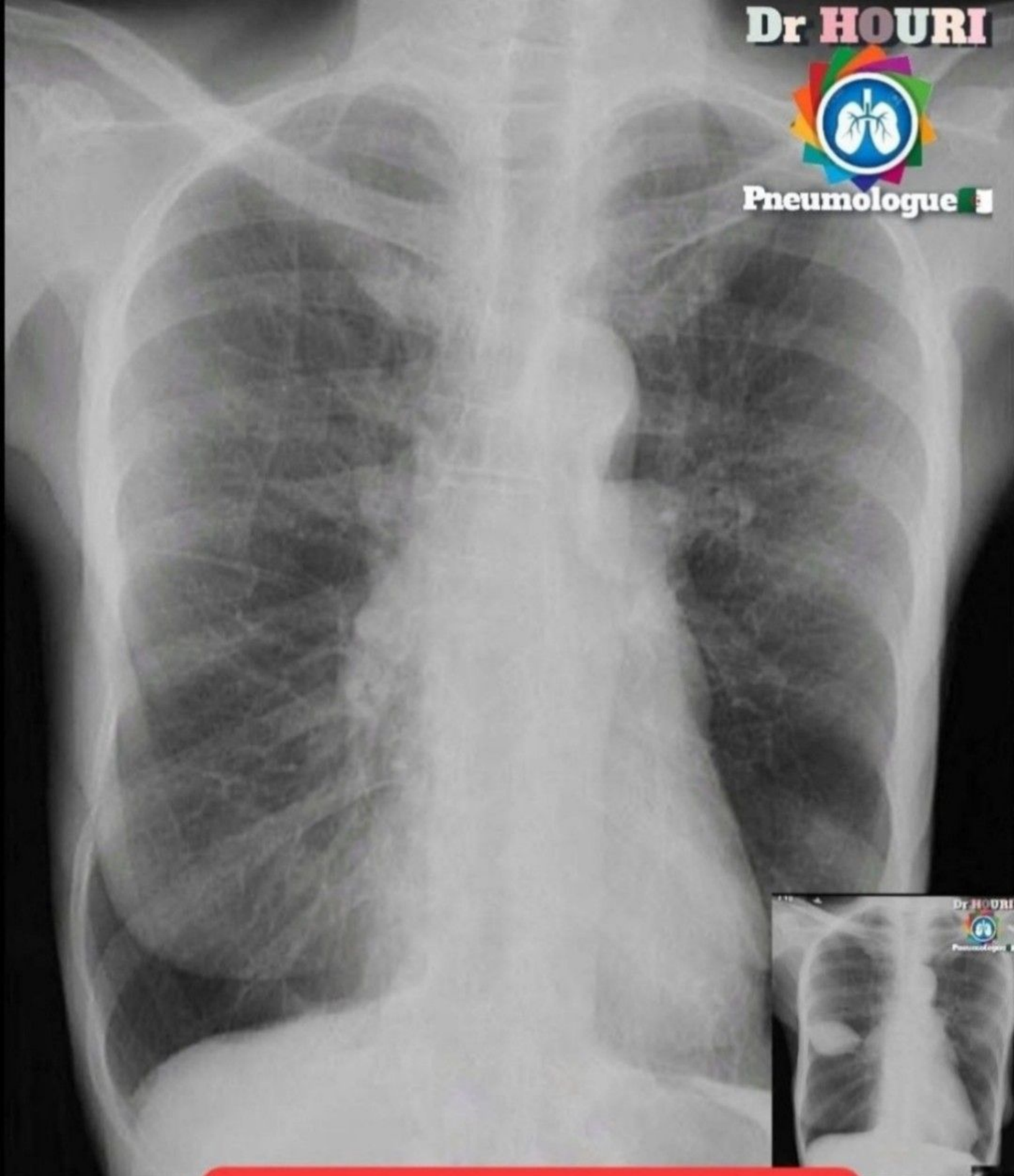
Pneumologue



Dr HOURI



Pneumologue



05 jours après Lasilix



R

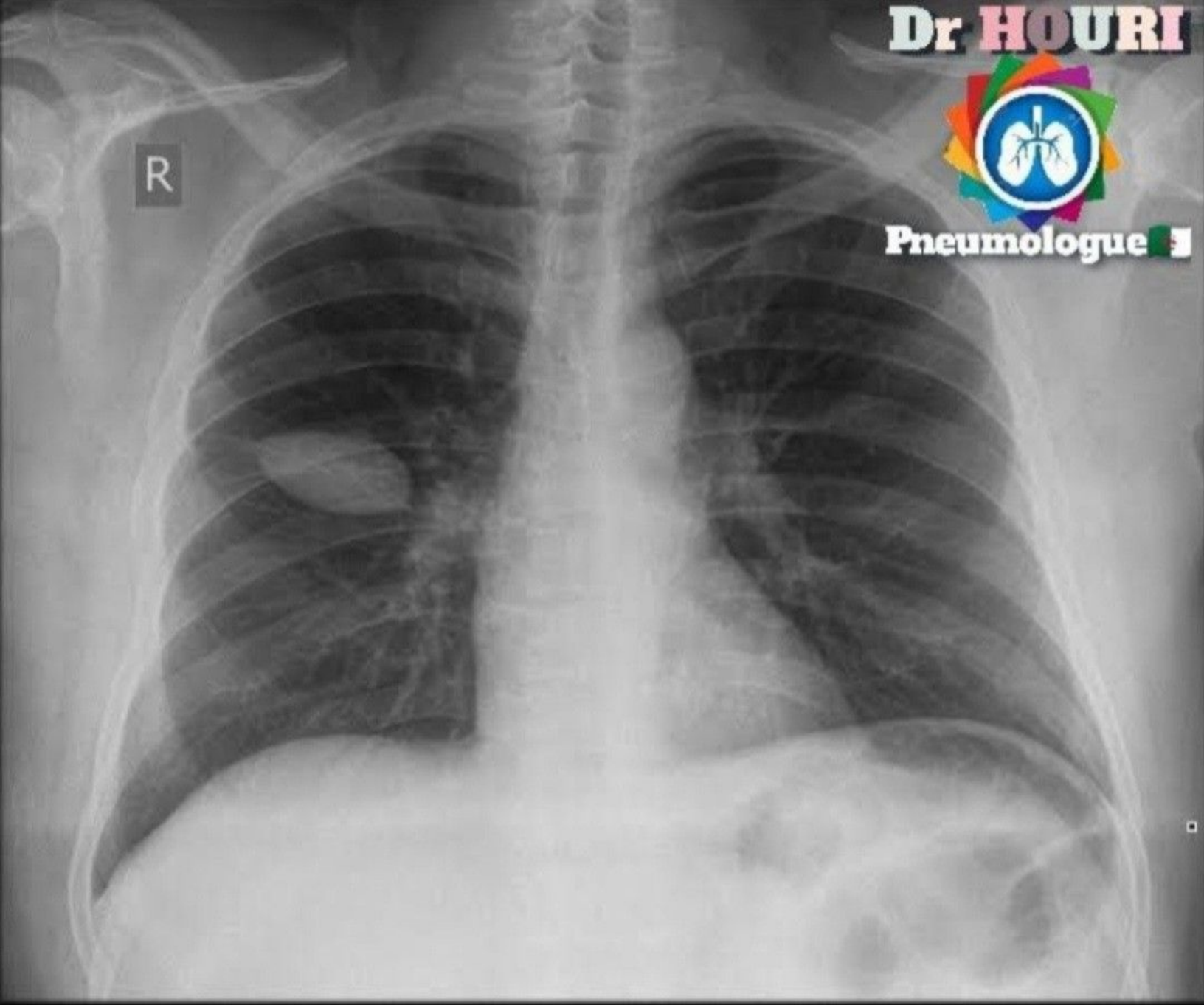


Dr HOURI



Pneumologue

R



Dr HOURI



Pneumologue

***03 jours
après lasilix.***

R

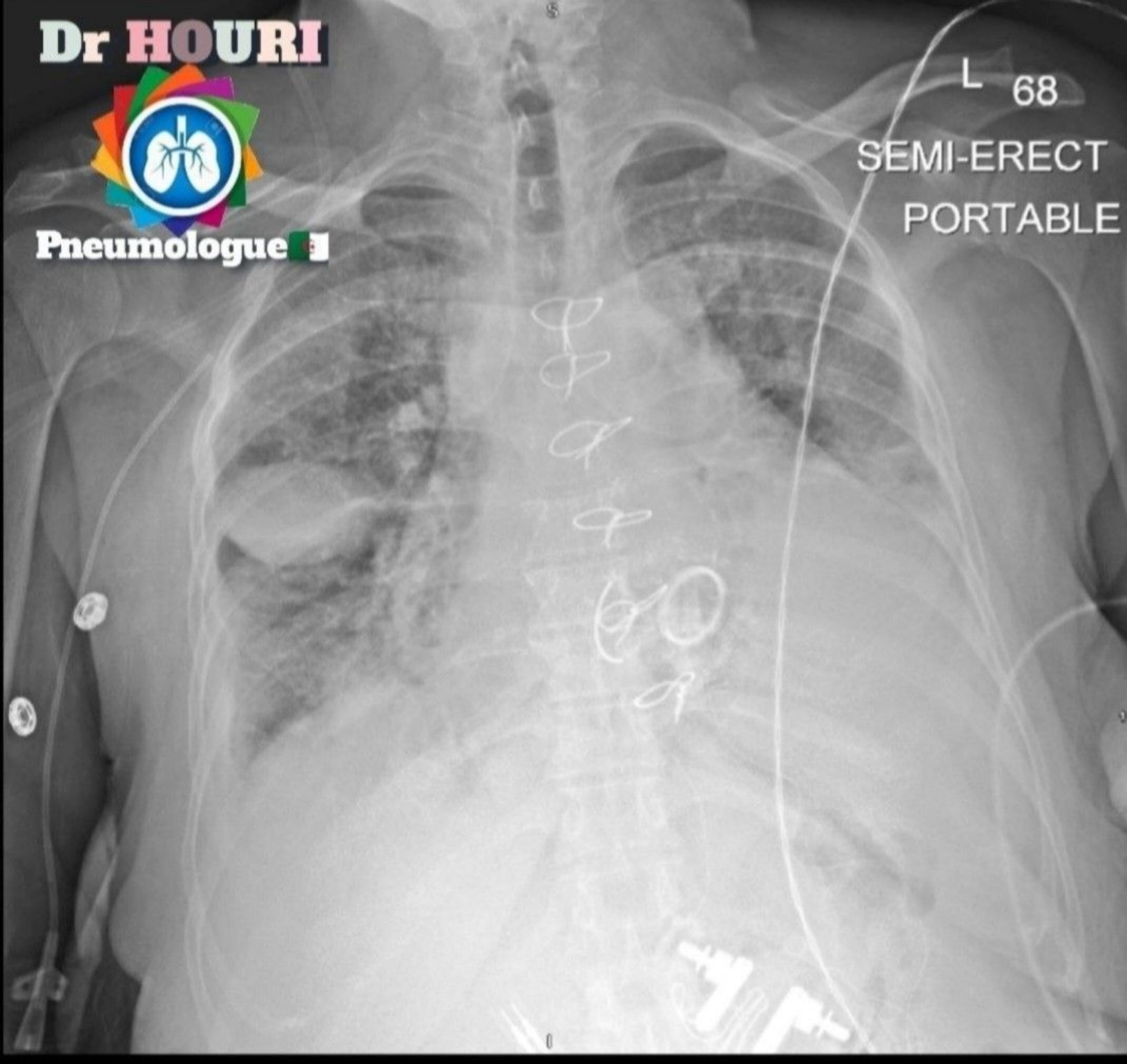
Dr HOURI



Pneumologue

L 68

SEMI-ERECT
PORTABLE



Dr HOURI



Pneumologue



4/24/2018

6- TÉTRALOGIE DE FALLOT

6- TÉTRALOGIE DE FALLOT :

La tétralogie de Fallot est une malformation cardiaque congénitale cyanogène (donc avec hypoxémie et cyanose) due à une anomalie du développement du septum conotroncal.

■ Radiographie thoracique
(classique)

Cœur en “sabot” (cœur en sabot = boot-shaped heart)

Hypovascularisation
pulmonaire

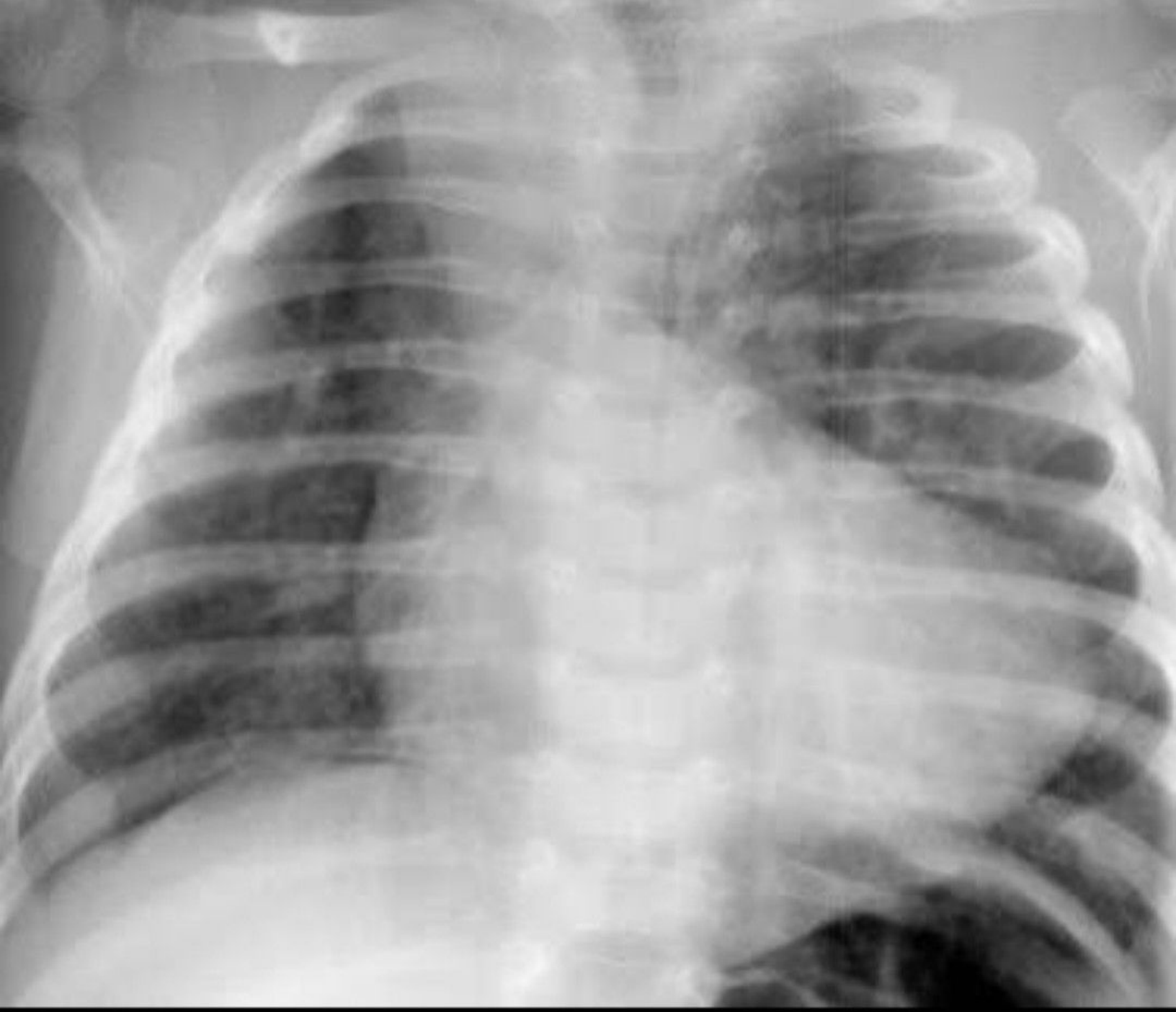
Arcade pulmonaire concave

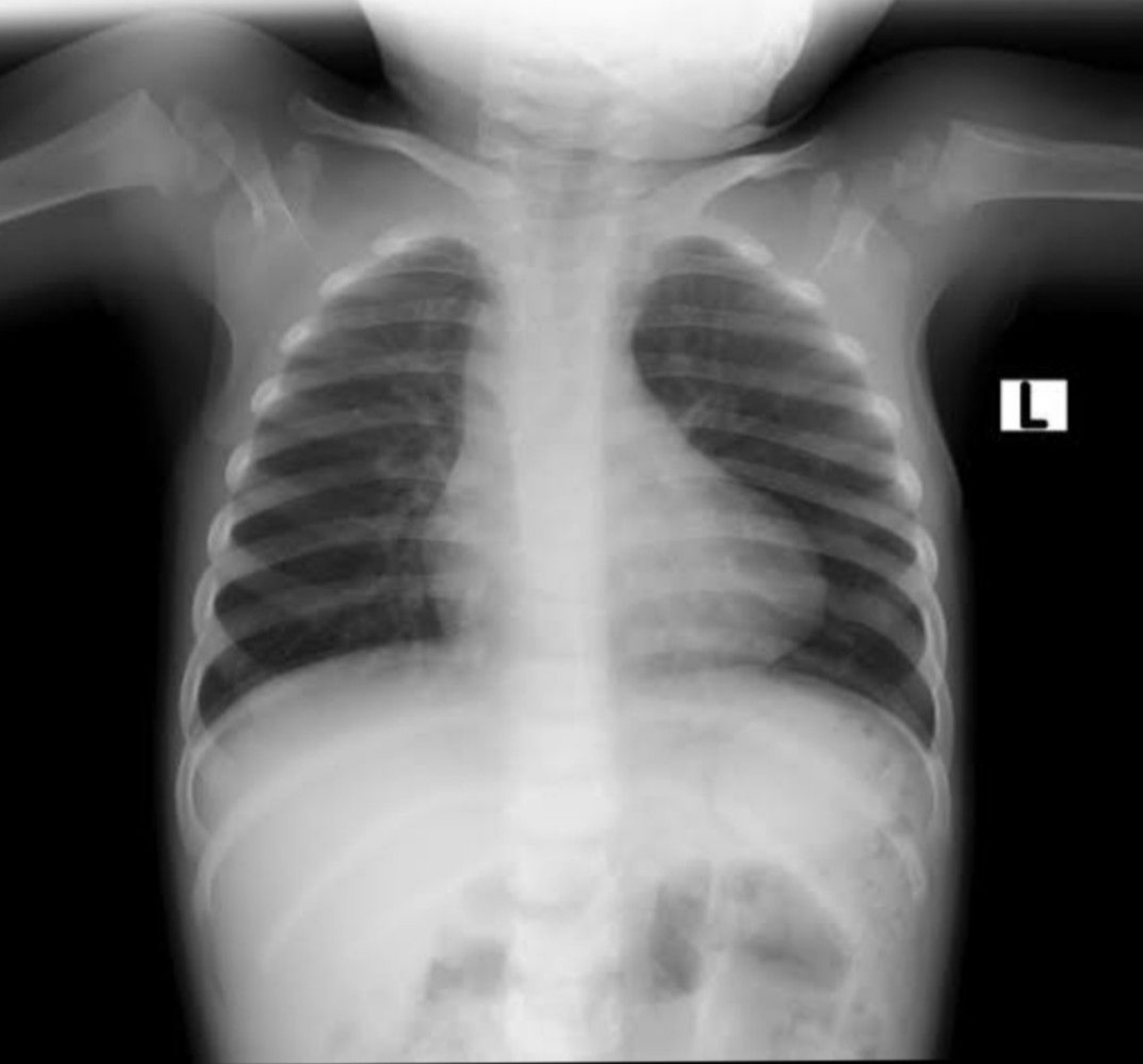
Dr HOURI



Pneumologue







Dr HOURI



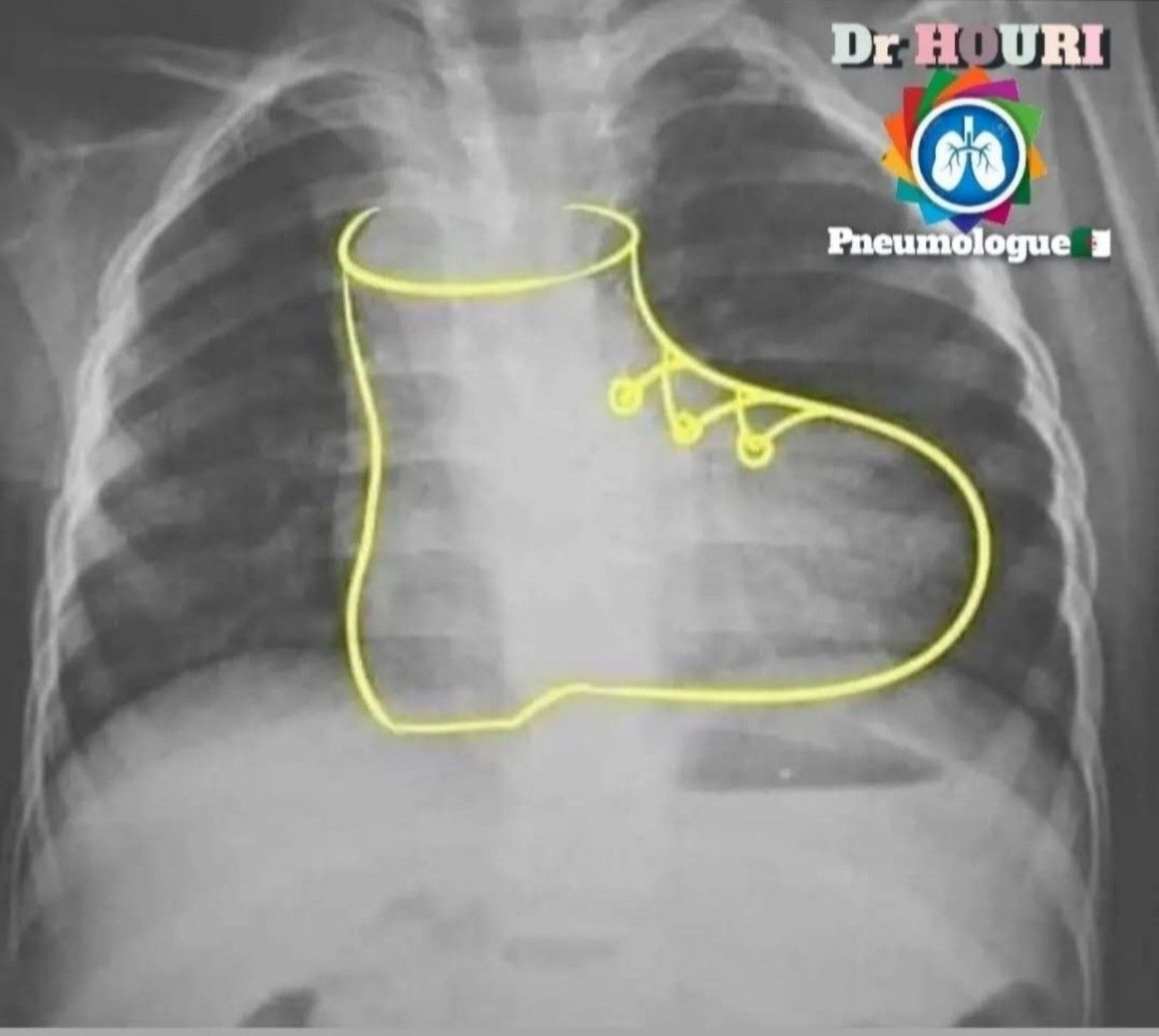
Pneumologue



Dr HOURI



Pneumologue





7-BOUTON AORTIQUE À
DROITE :

7-BOUTON AORTIQUE À DROITE :

Le “bouton aortique à droite” (ou arc aortique droit) correspond à une saillie de la crosse aortique du côté droit du médiastin sur la radiographie thoracique.

Normalement, le bouton aortique est visible à gauche.

✓ Il s'agit d'une variation anatomique, Il survient chez moins de 1 personne sur 1000.



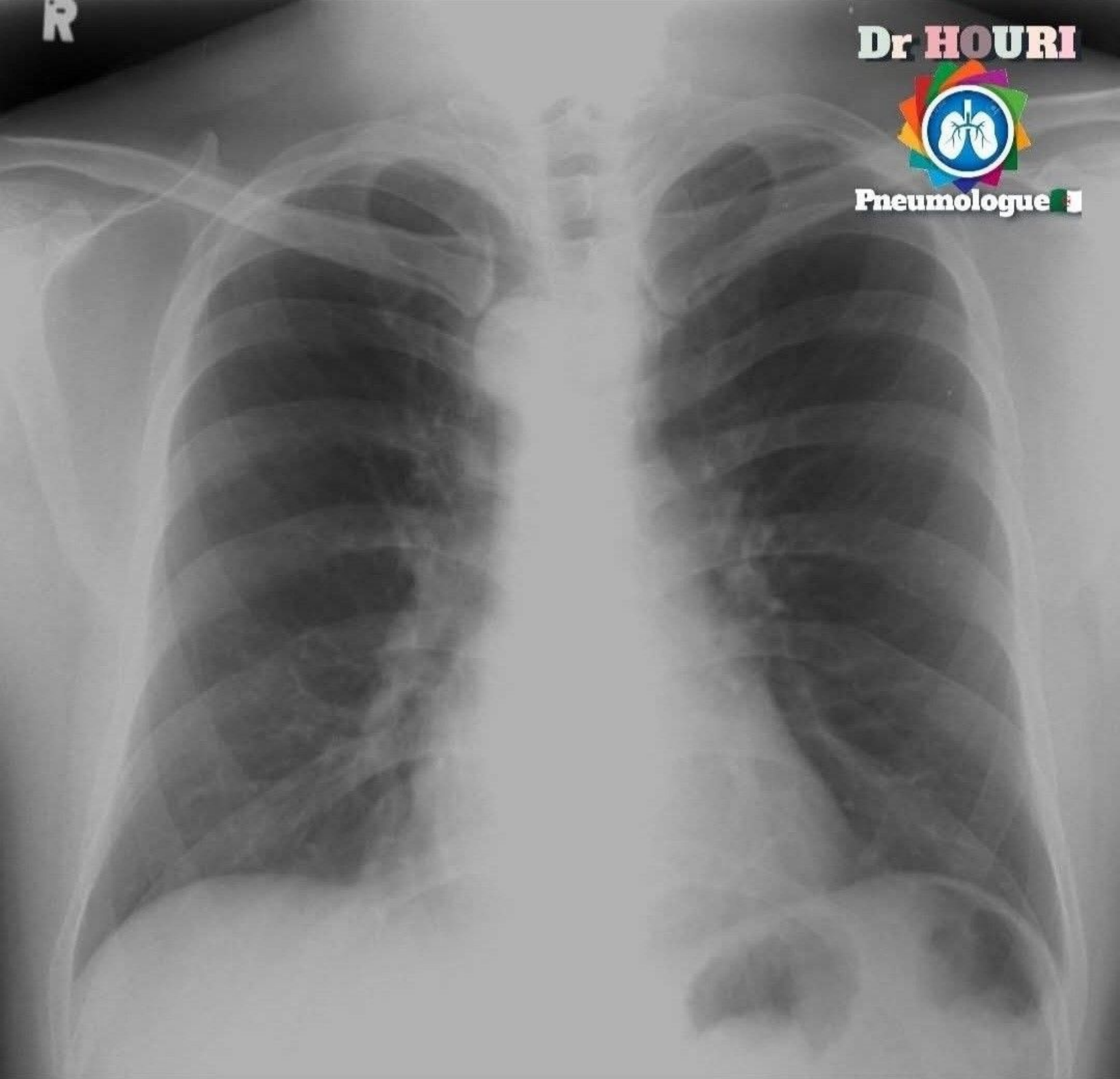
À la radiographie thoracique
On peut voir :
Convexité aortique du côté droit
Trachea parfois légèrement déviée
Silhouette médiastinale
asymétrique

R

Dr HOURI

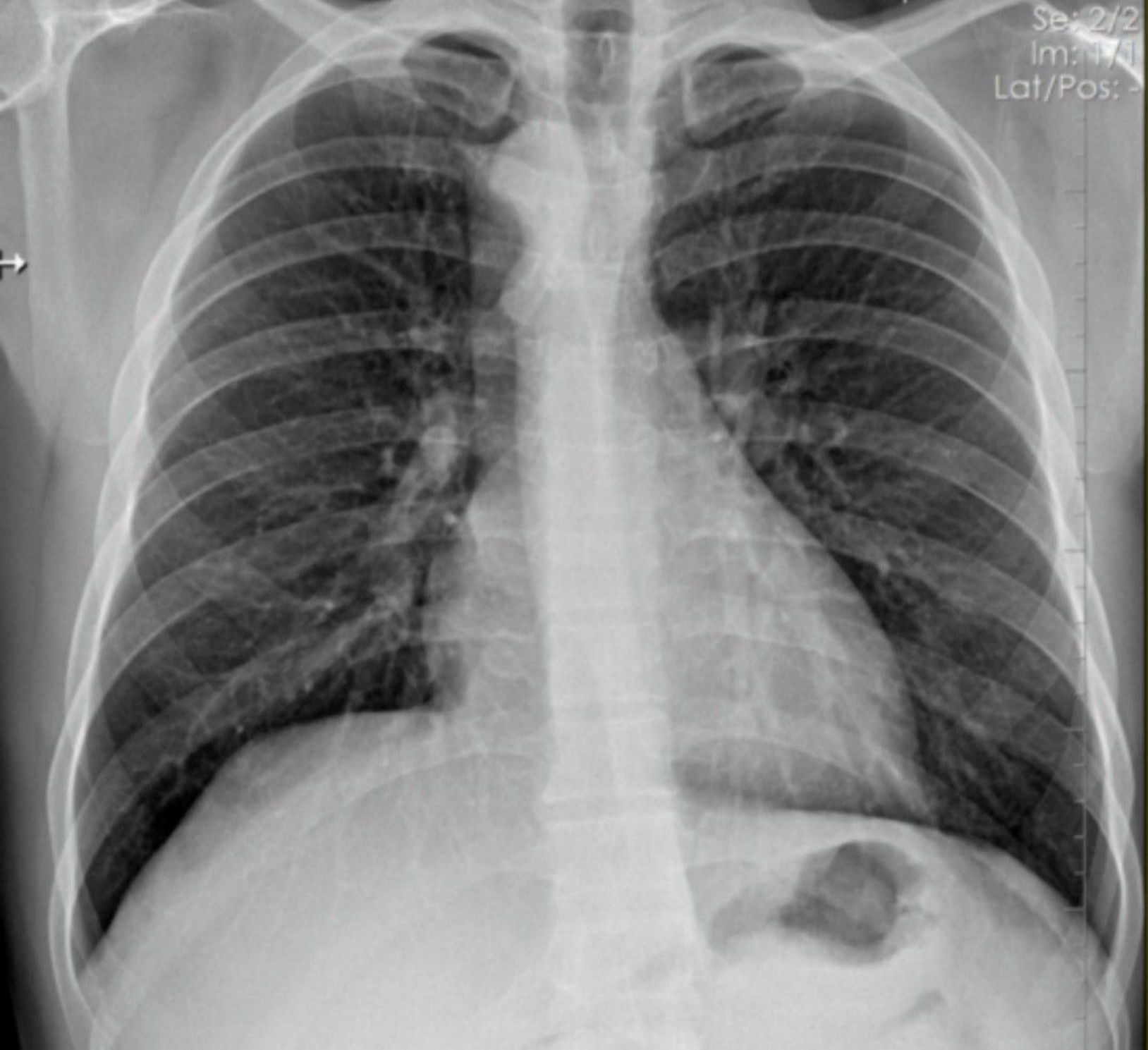


Pneumologue

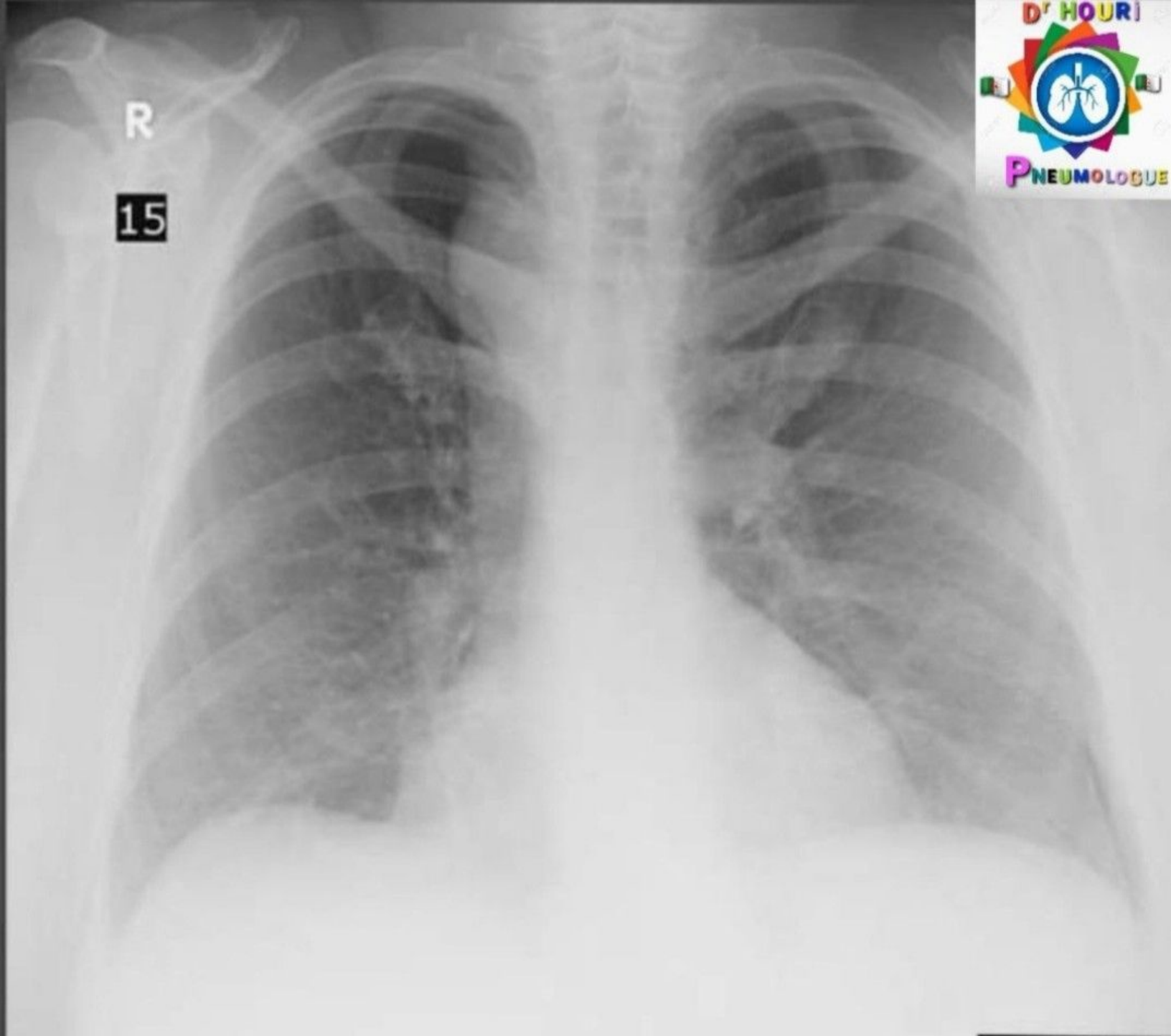




Se: 2/2
Im: 1/1
Lat/Pos: -







**8-Le retour veineux pulmonaire
anormal total
(RVPAT):**

8-Le retour veineux pulmonaire anormal total (RVPAT):

■ La radiographie thoracique montre **un aspect en « huit »** ou **en « bonhomme de neige »**. La moitié supérieure de la figure en huit était formée par la veine cave supérieure dilatée du côté droit, la veine brachiocéphalique gauche en haut et la veine verticale dilatée du côté gauche. La partie inférieure de la figure en huit était formée par l'oreillette et le ventricule droits dilatés

■ Le retour veineux pulmonaire anormal total (RVPAT) est une anomalie cardiaque congénitale cyanotique avec une anatomie de drainage anormale de l'ensemble du système veineux pulmonaire. Cela contraste avec le retour veineux pulmonaire anormal partiel (PAPVR) où seule une partie de l'anatomie veineuse pulmonaire est anormale.

Dr HOURI



Pneumologue 



Dr HOURI



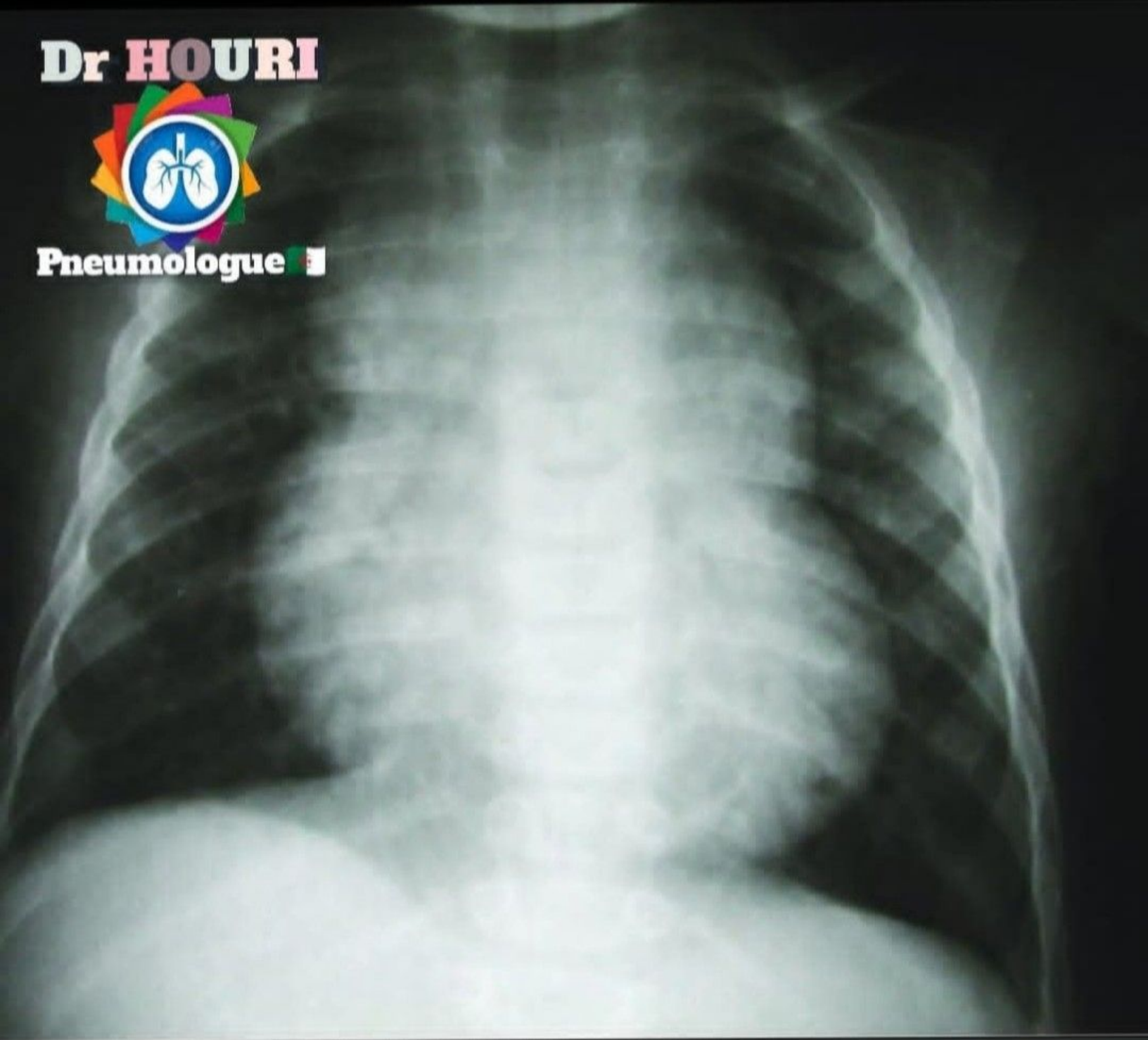
Pneumologue 



Dr HOURI



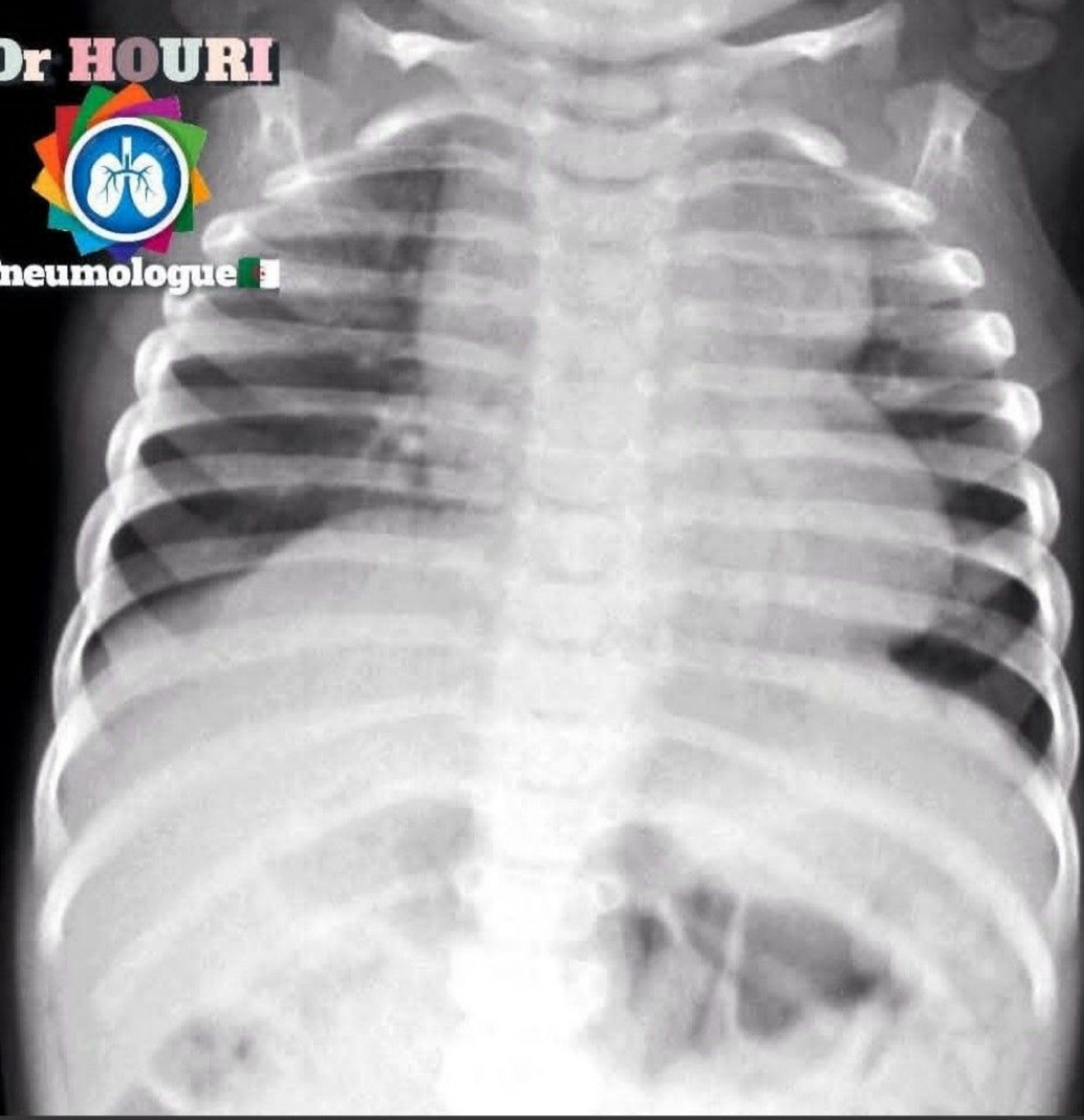
Pneumologue



Dr HOURI



Pneumologue 



9-ŒDÈME IGÛE PULMONAIRE UNILATÉRAL

9-ŒDÈME IGÛE PULMONAIRE UNILATÉRAL

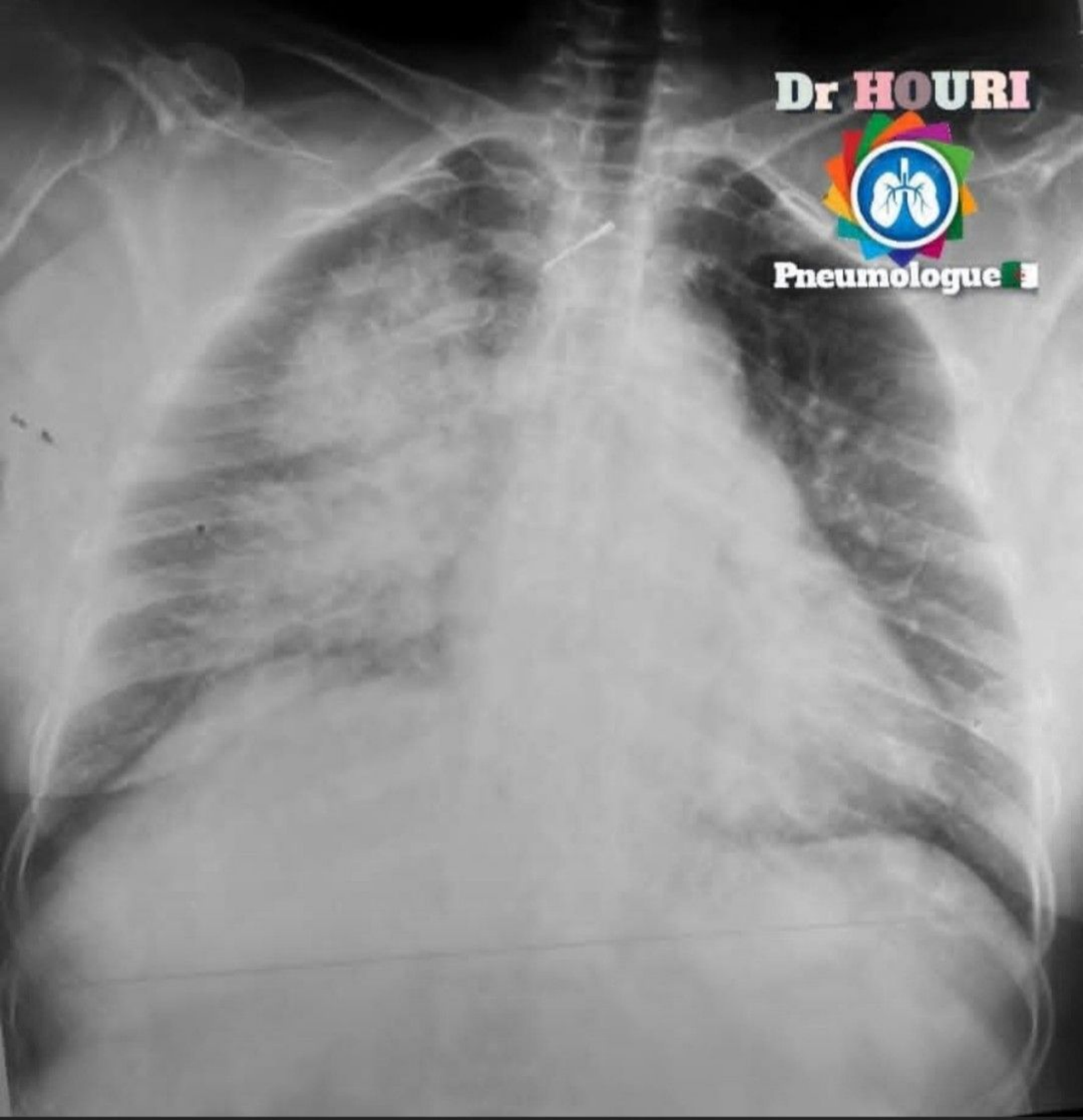
✓ L'œdème pulmonaire aigu(OAP) unilatéral est une entité radioclinique rare. Il est secondaire à de multiples pathologies spécifiques et rares. L'insuffisance mitrale ischémique fonctionnelle secondaire à une nécrose myocardique est l'une des étiologies rares impliquée dans sa genèse.

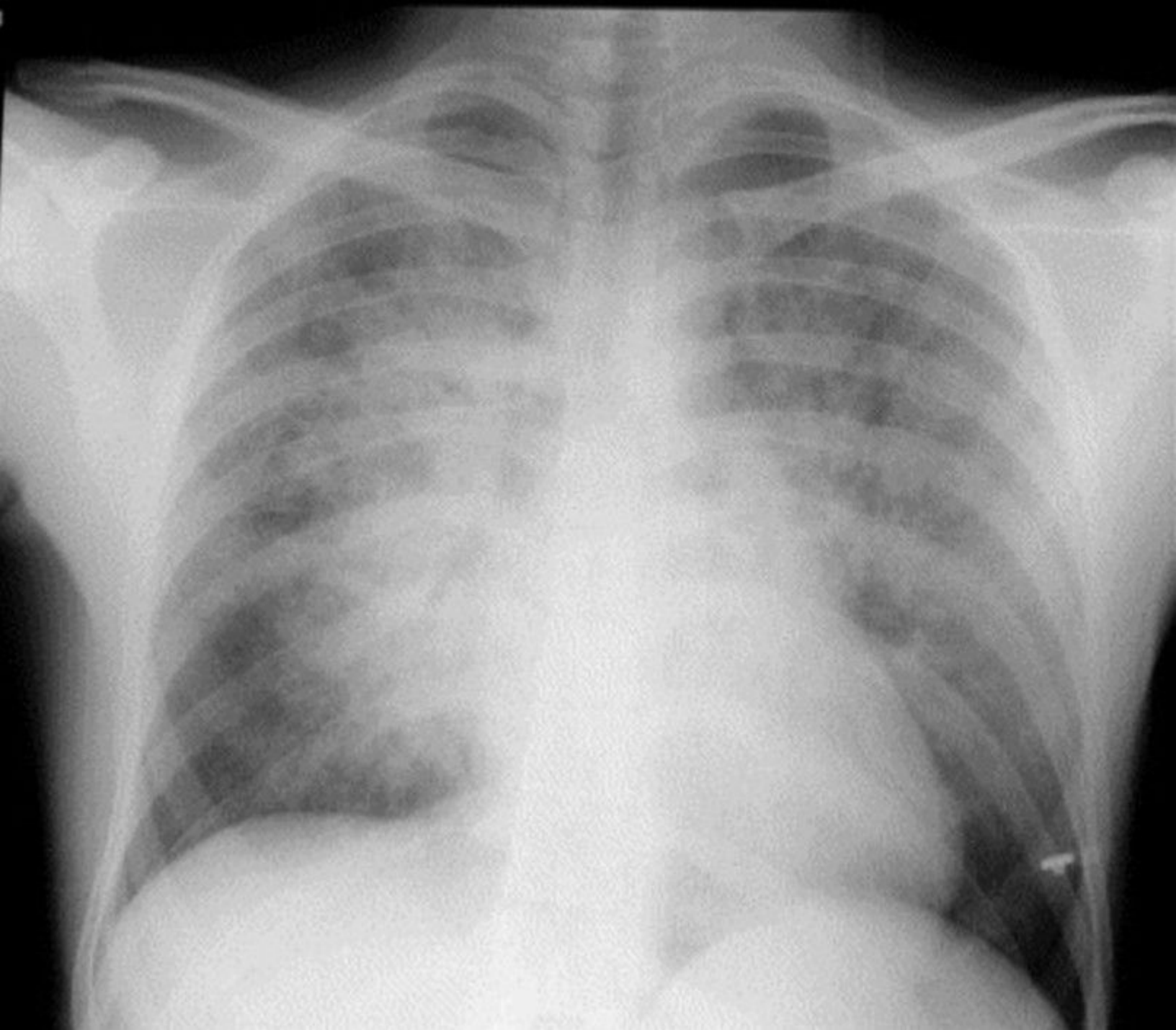
↴ Il s'agit d'une patiente qui a présenté un IDM compliqué d'insuffisance mitrale excentrique ,

Dr HOURI



Pneumologue





10- CALCIFICATION
PÉRICARDIQUE OU
PÉRICARDITE CONSTRICTIVE

10- CALCIFICATION PÉRICARDIQUE OU PÉRICARDITE CONSTRICTIVE

La péricardite constrictive est une atteinte chronique du péricarde où celui-ci devient épais, fibreux et rigide, empêchant le cœur de se remplir normalement pendant la diastole.

Calcifications présentes → très évocateur de péricardite constrictive ancienne

■ Radiographie thoracique
Calcifications péricardiques
visibles (aspect en coquille autour
du cœur)

Taille cardiaque souvent normale
ou peu augmentée

Dr HOURI



Pneumologue 

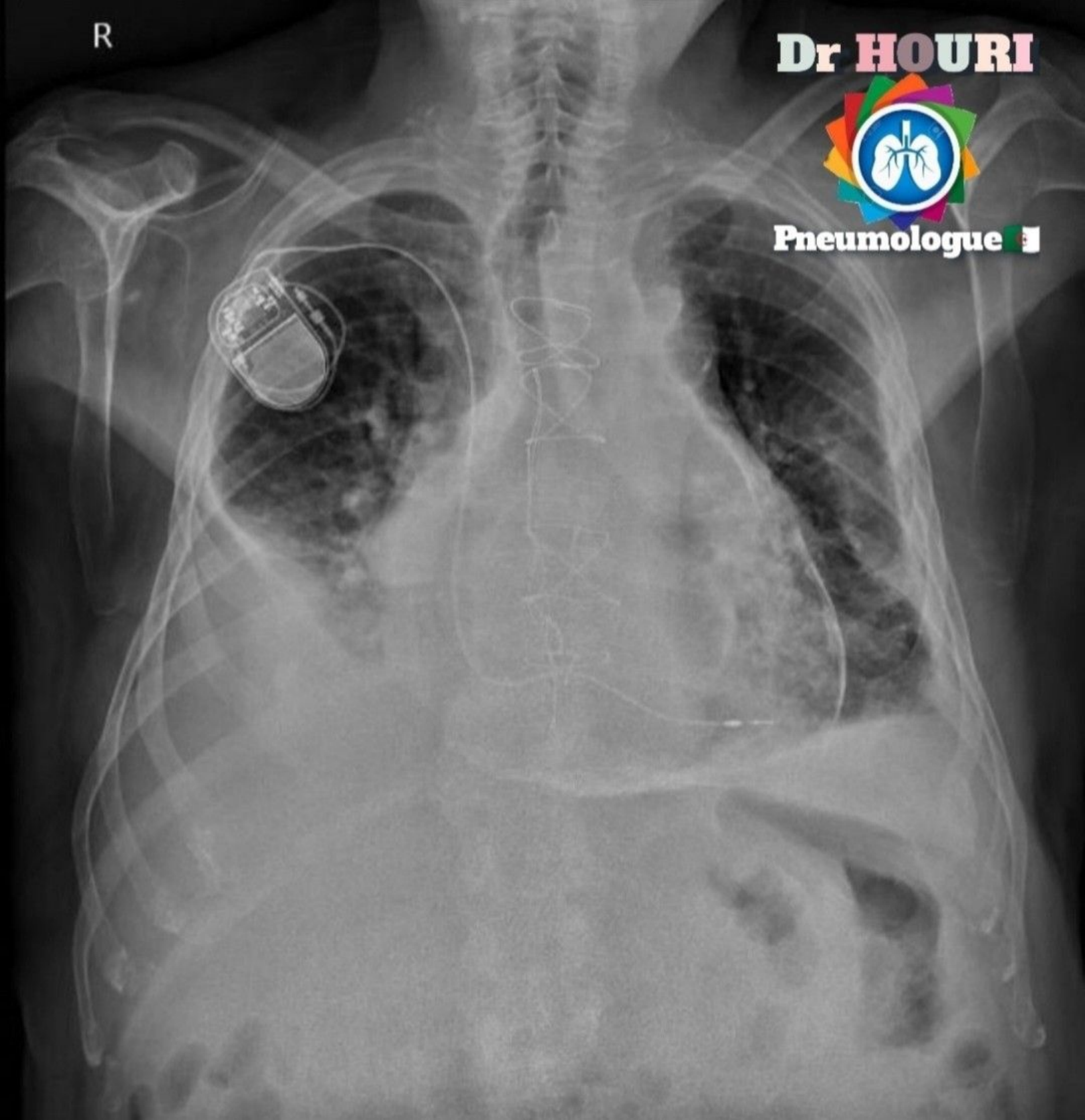


R

Dr HOURI



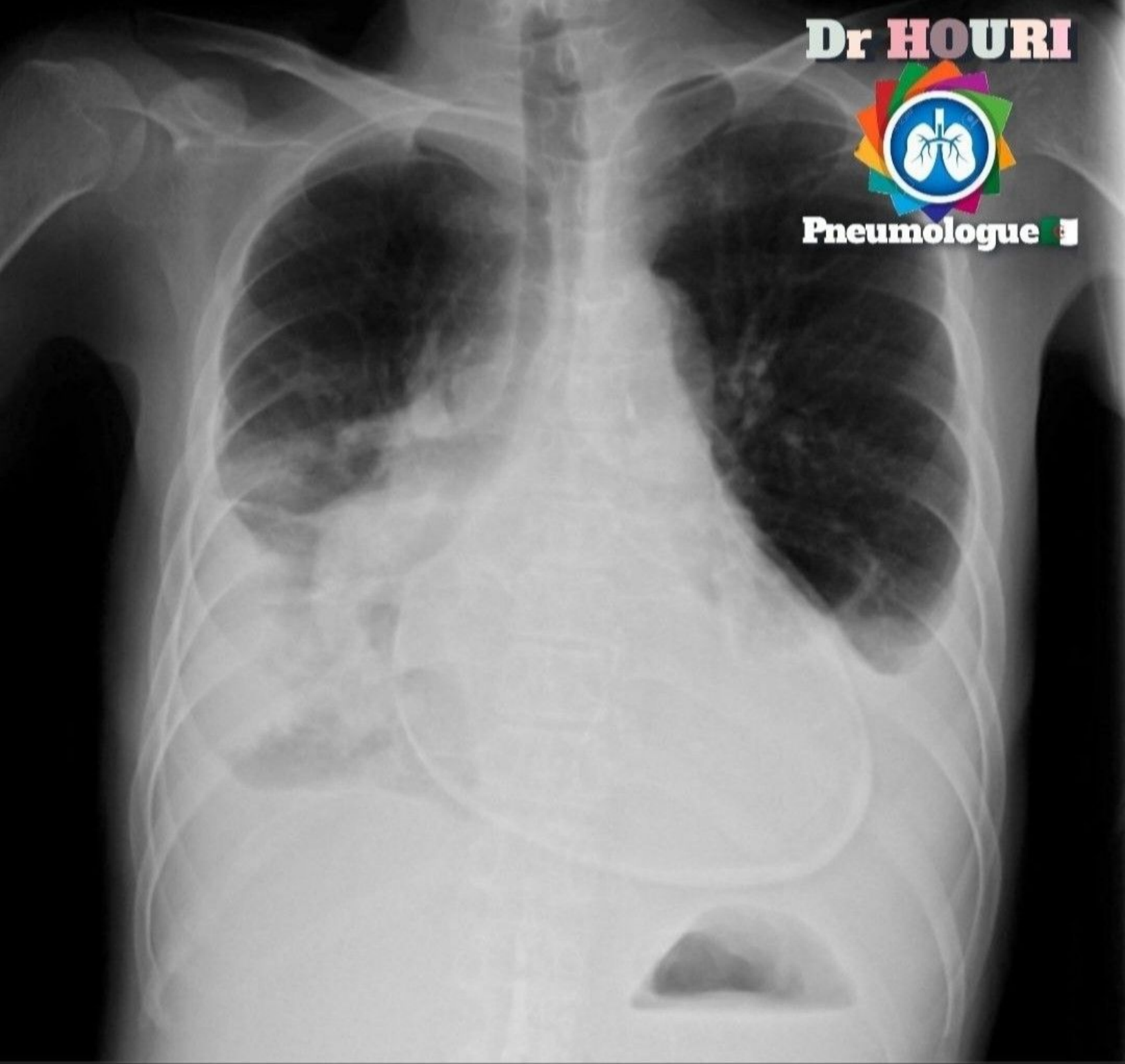
Pneumologue 



Dr HOURI



Pneumologue



Dr HOURI



Pneumologue



Dr HOURI



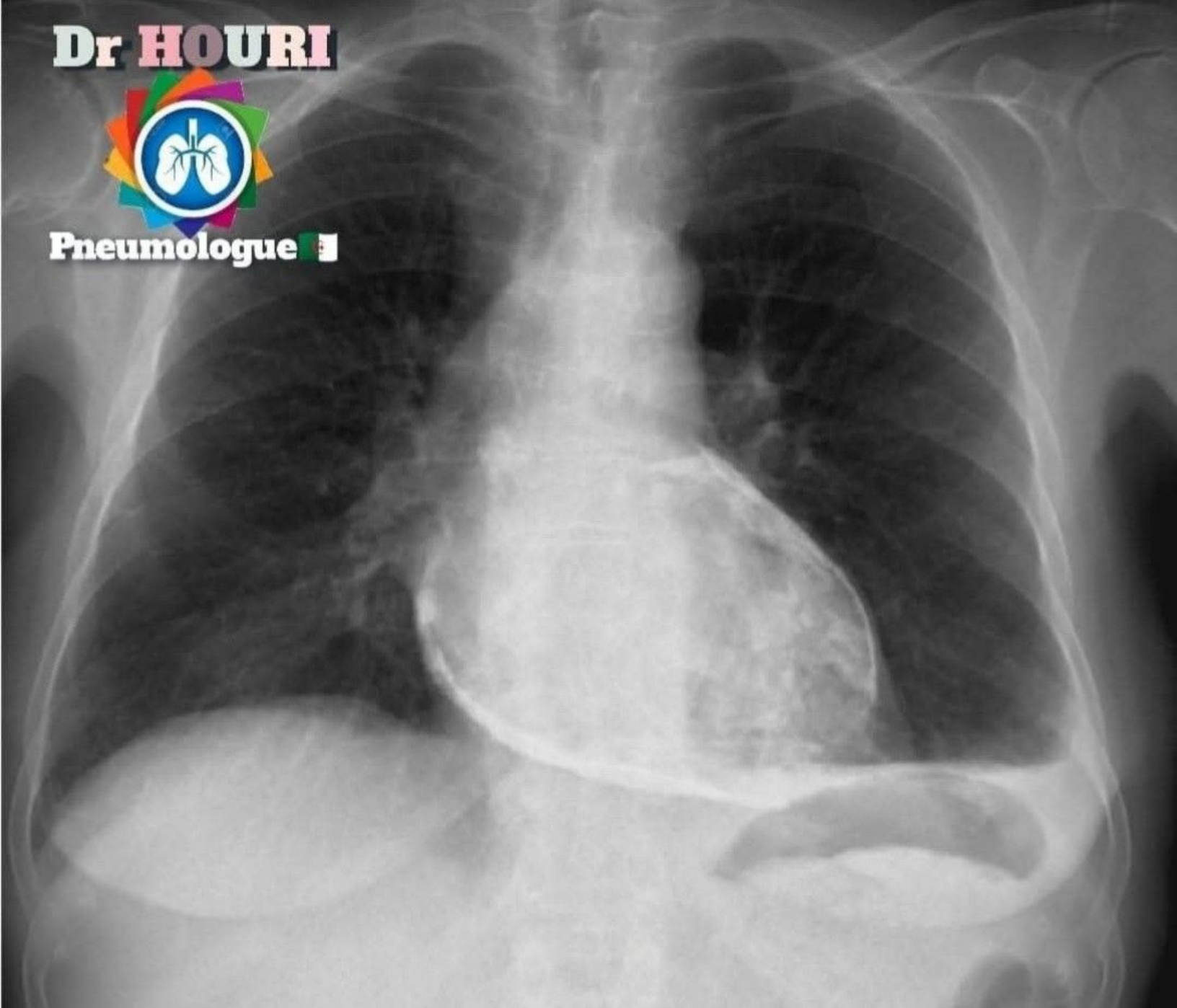
Pneumologue 



Dr HOURI



Pneumologue 



11- ANÉVRISME DU BOUTON AORTIQUE

11- ANÉVRISME DU BOUTON AORTIQUE :



Quand suspecter un anévrisme du bouton aortique ?



Devant des anomalies du bouton aortique (arc aortique gauche) :

1. Augmentation de taille du bouton aortique

Saillie anormalement volumineuse
Convexité exagérée vers la gauche

2. Contours anormaux

Bord externe très bombé, arrondi
Perte de la finesse habituelle du contour



La radiographie permet une suspicion seulement



Le diagnostic de certitude repose sur :

TDM thoracique (angioscanner)
ou IRM thoracique

Dr. HOURI



Pneumologue



Dr Houri



Pneumologue ■



12- LES LIGNES DE KERLEY B

12- LES LIGNES DE KERLEY B

Les lignes de Kerley B sont un signe radiologique visible sur une radiographie thoracique, généralement associé à une atteinte interstitielle pulmonaire, surtout d'origine cardiaque.



Causes principales

Œdème pulmonaire cardiogénique
(cause la plus fréquente)

Insuffisance cardiaque gauche

Lymphangite carcinomateuse (plus rare)



Aspect radiologique

Lignes fines, droites

Horizontales

Bien visibles aux bases

Multiples et bilatérales

Dr HOURI



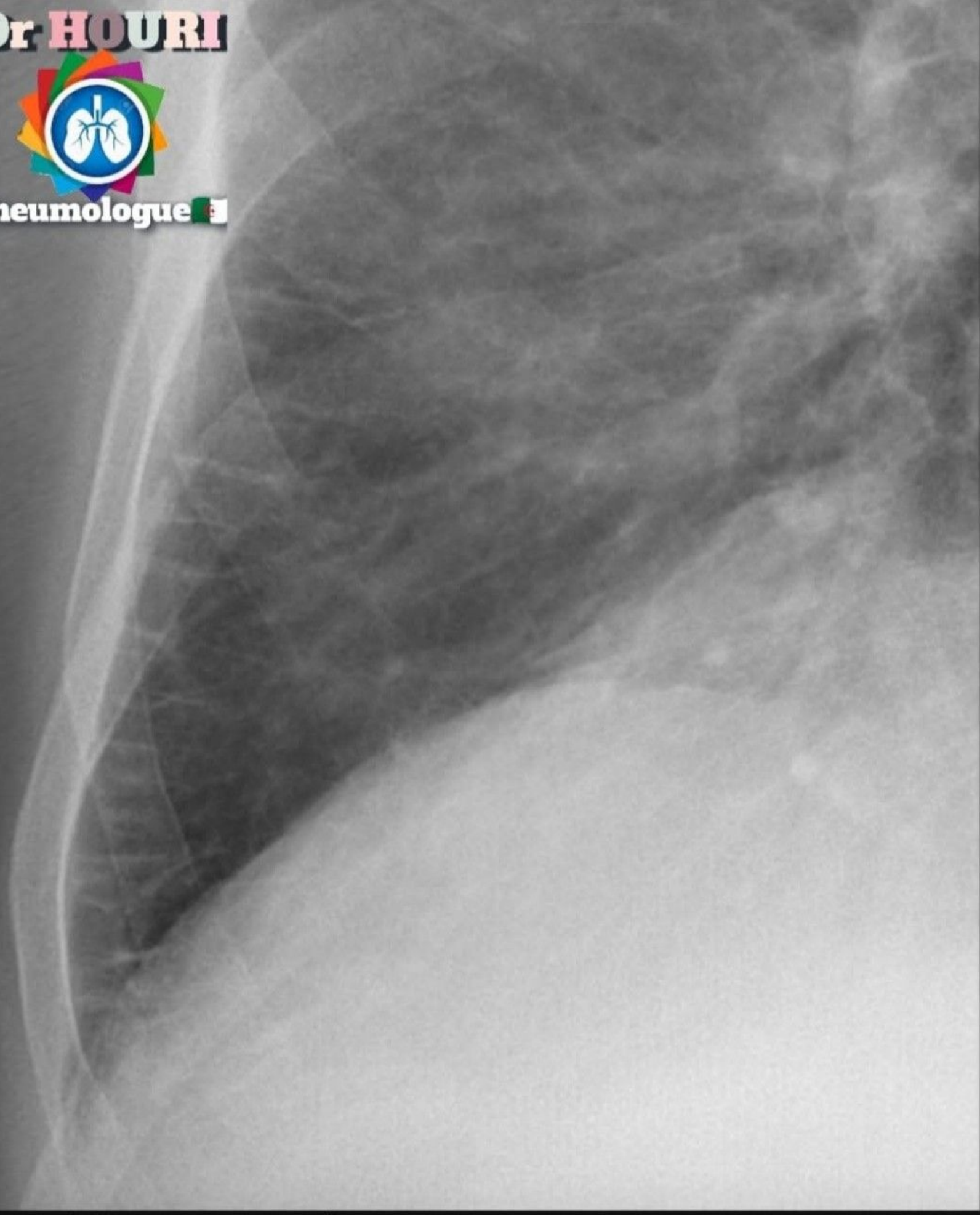
Pneumologue



Dr HOURI



Pneumologue





Dr HOURI

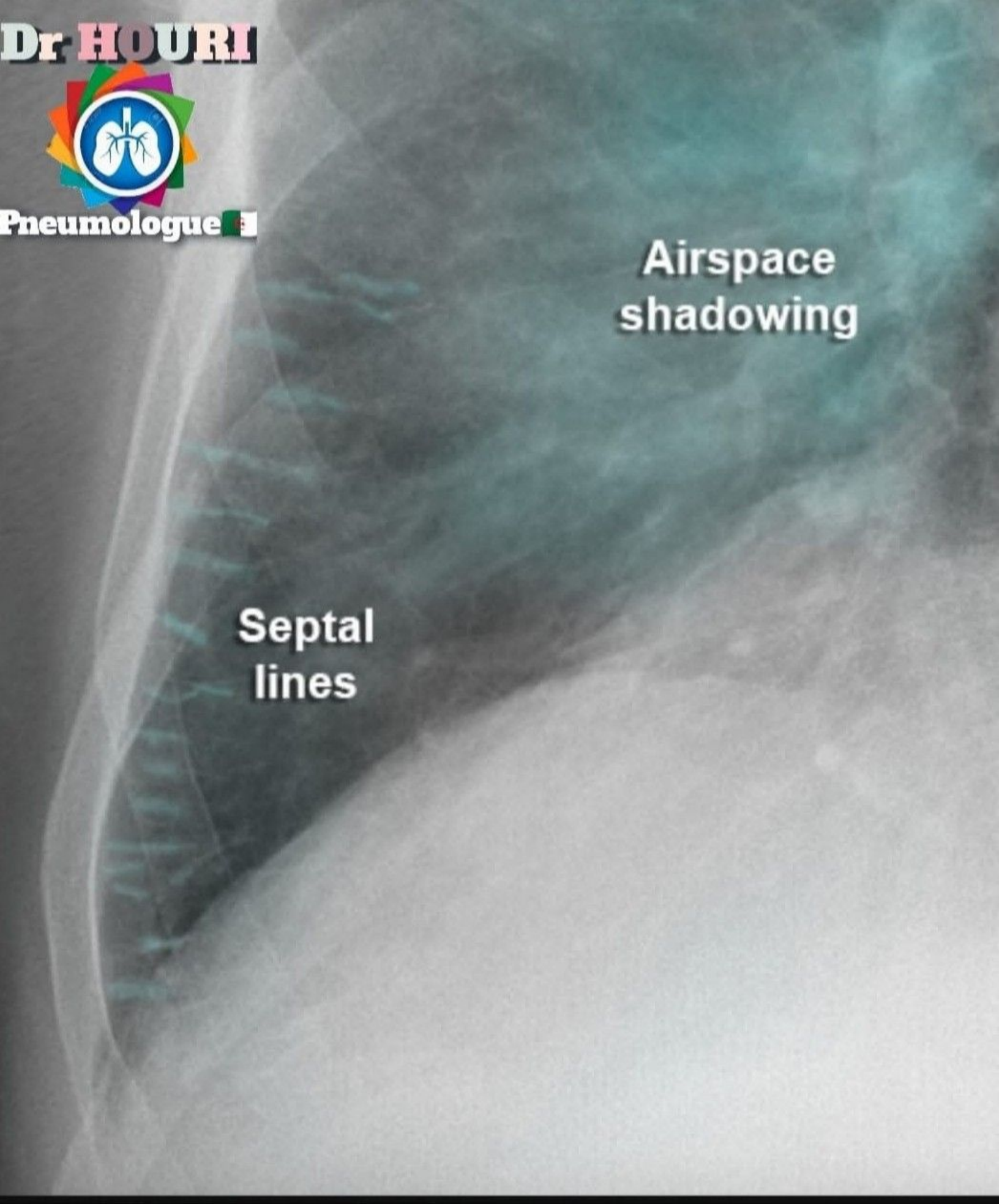


Pneumologue



**Airspace
shadowing**

**Septal
lines**



13- PNEUMOPERICARDE ET HYDRO_PNEUMOPÉRICARDE

13- PNEUMOPERICARDE ET HYDRO_PNEUMOPÉRICARDE

Pneumopéricarde

 Présence d'air seul dans le sac péricardique



Signes radiographiques :
Clarté gazeuse encerclant le cœur
Limite nette, souvent continue
autour du cœur
Ne dépasse pas les attaches du
péricarde (reste localisé)

Hydropneumopéricarde

 Présence d'air + liquide dans le péricarde



Signes radiographiques :
Niveau hydro-aérique horizontal
autour du cœur (très évocateur)
Image en double composante :
partie supérieure claire (air)
partie inférieure opaque (liquide)
Contours cardiaques bien visibles
mais modifiés

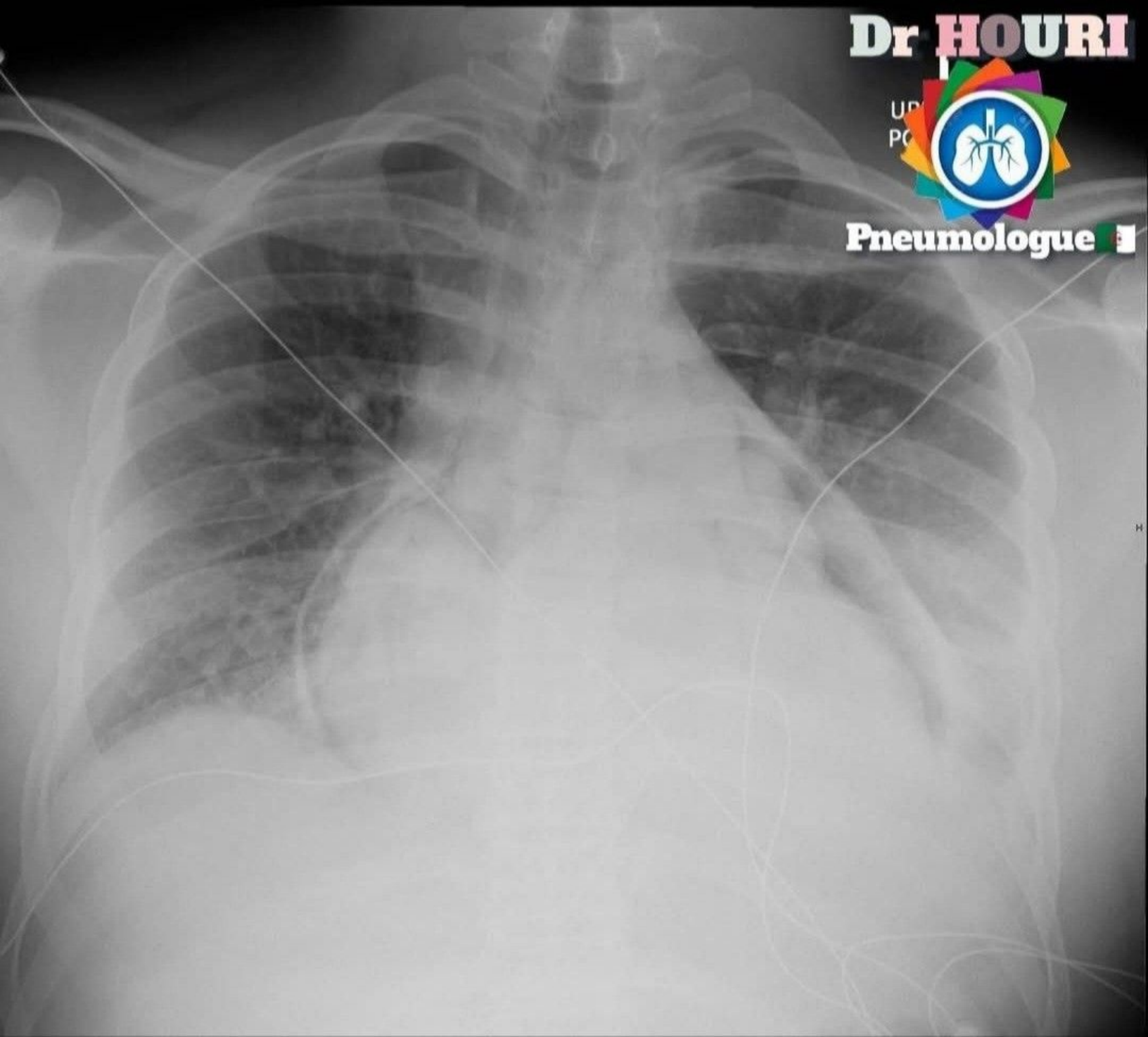


Dr HOURI

UP
PC



Pneumologue



Dr HOURI



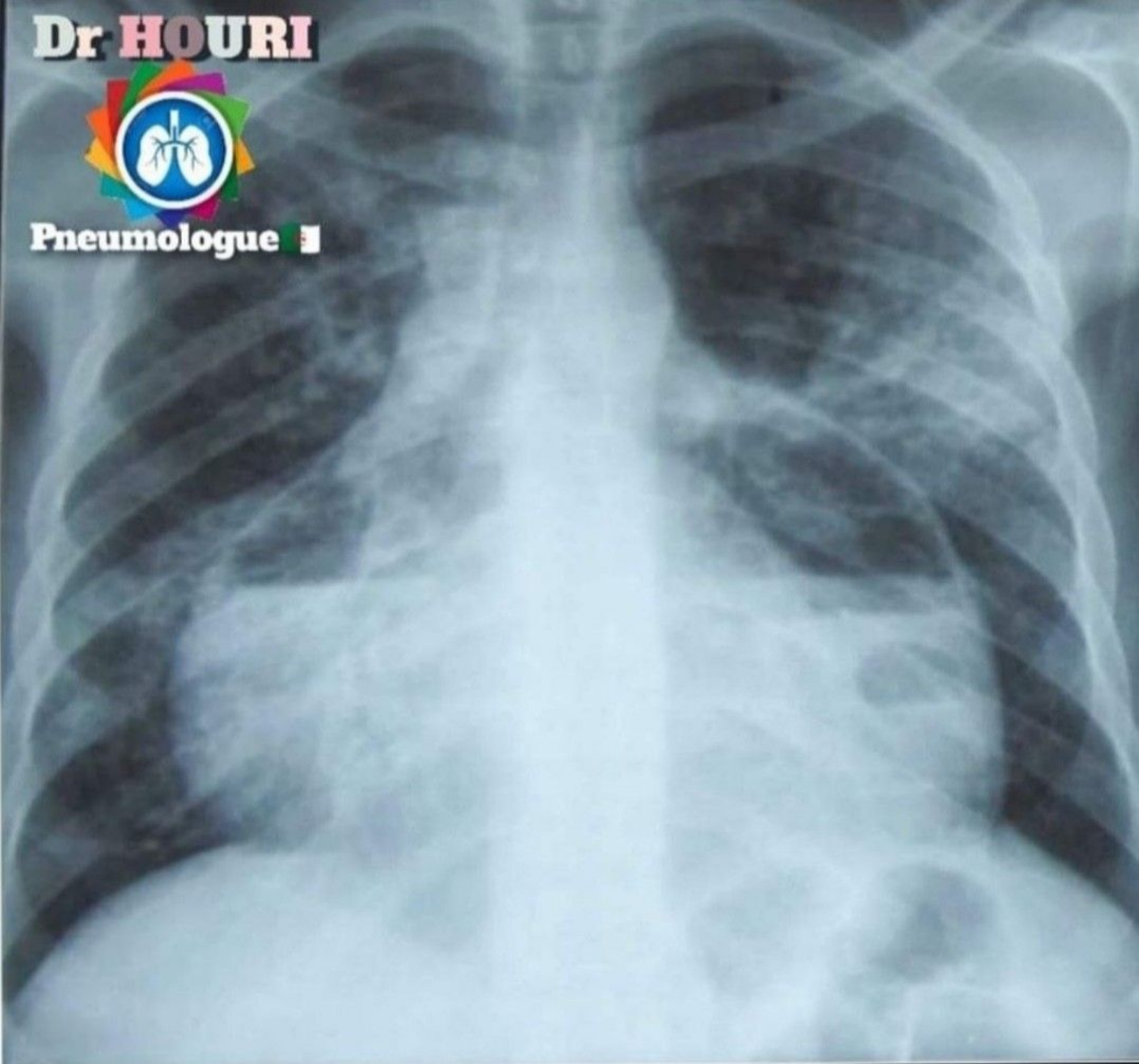
Pneumologue 



Dr HOURI



Pneumologue



R-AP

Dr HOURI



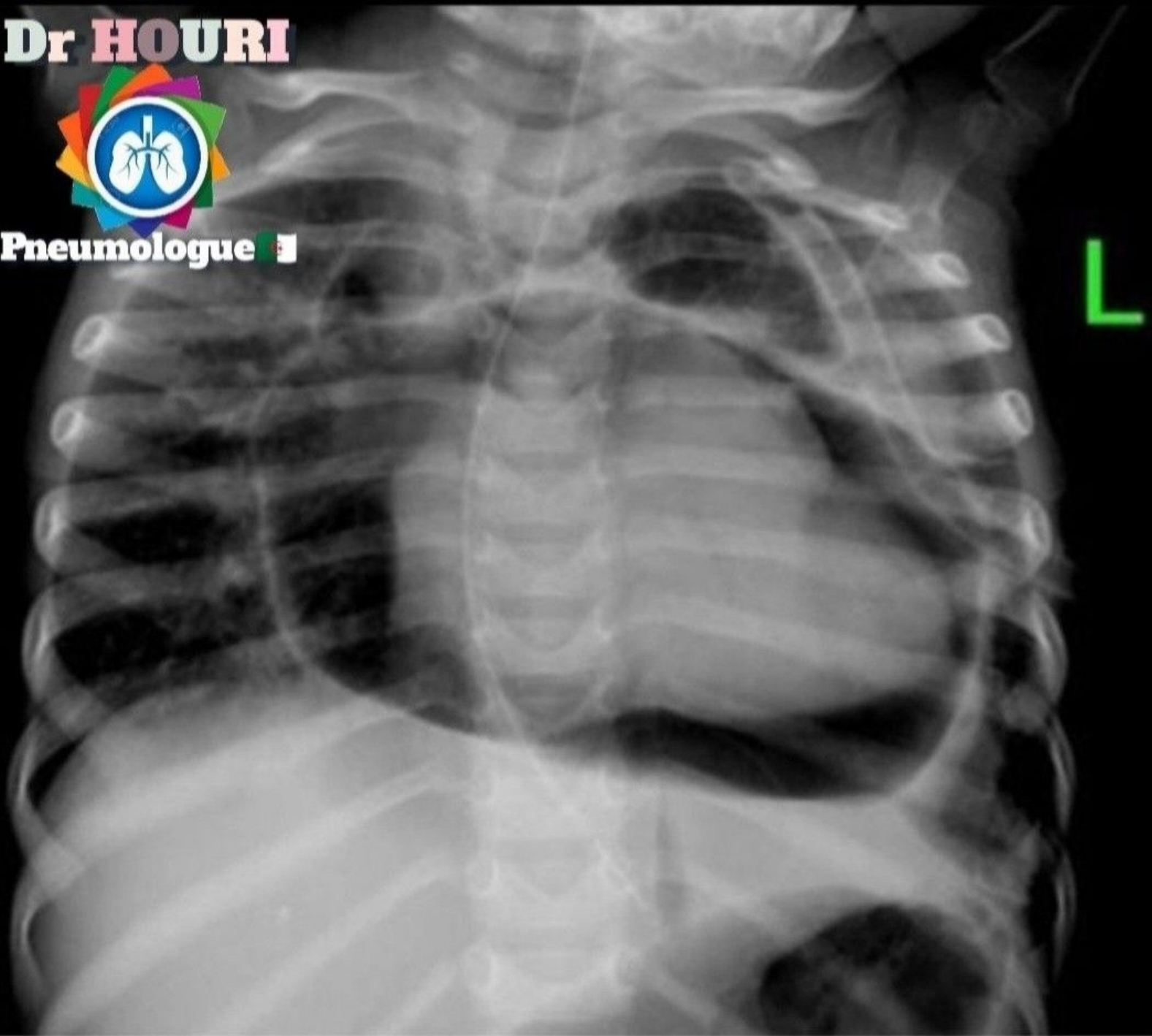
Pneumologue 



Dr HOURI



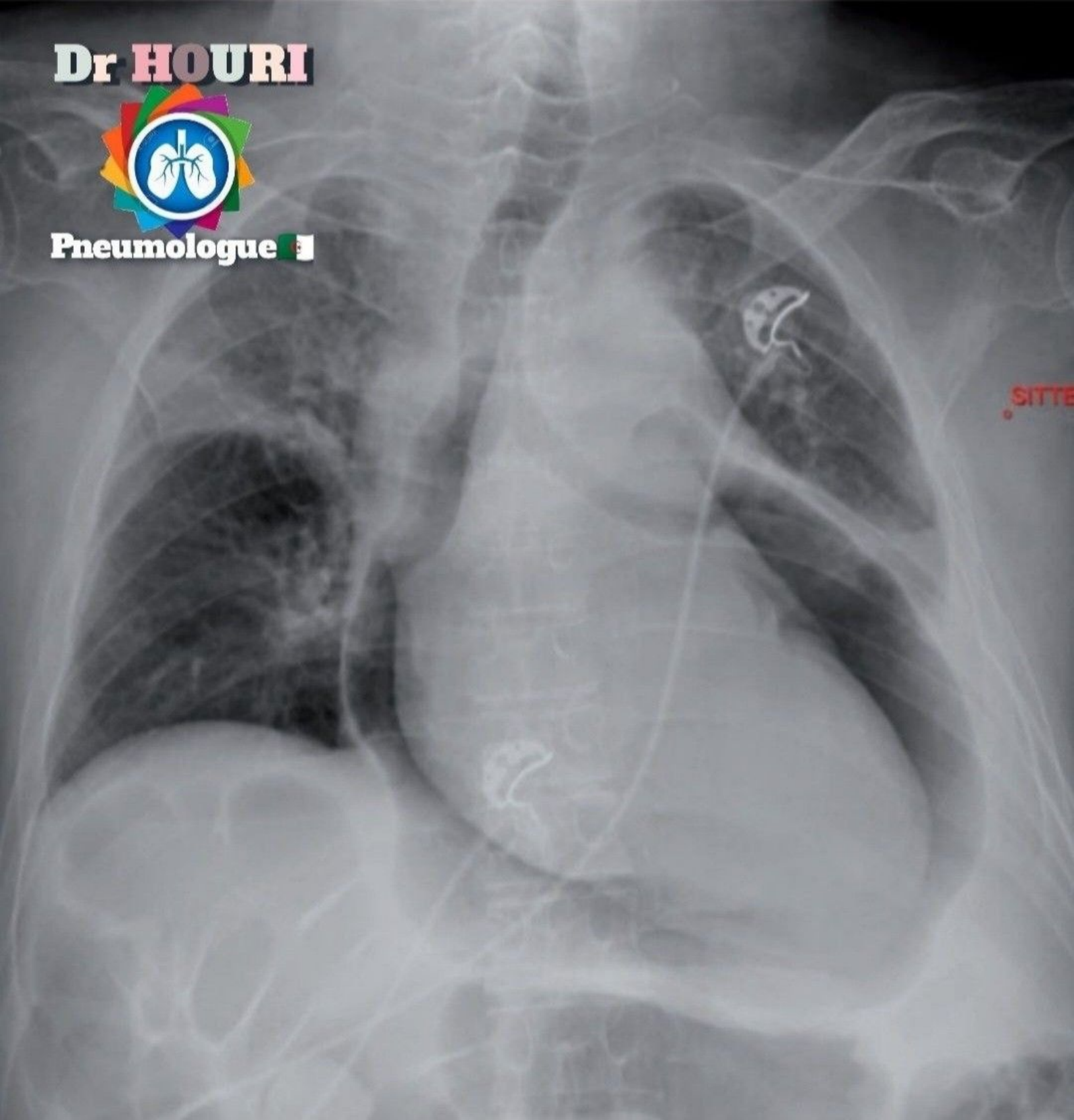
Pneumologue 



Dr HOURI



Pneumologue 



Dr HOURI



Pneumologue 

Dr HOURI



Pneumologue ■



15- ANÉVRISME DE L'AORTE THORACIQUE

15- ANÉVRISME DE L'AORTE THORACIQUE :

Un anévrisme de l'aorte thoracique est une dilatation anormale et permanente d'un segment de l'aorte situé dans le thorax. On parle généralement d'anévrisme lorsque le diamètre dépasse 1,5 fois la normale.



Signes radiologiques
(radiographie thoracique)

▼ Élargissement du médiastin

▼ Bombement du bouton
aortique

▼ Déviation de la trachée

▼ Calcifications pariétales



Angio-TDM (scanner) ★
(examen clé)

27
/AMMA, 45Y R

Dr HOURI



Pneumologue

m: 1.00x
096 L:2048 (Auto)

SRI JAYADEVA INSTITUTE OF CARDIO
DFOV: 35.2 x 35.2

REA

zy
/AMMA, 45Y R

Dr HOURI



Aug 2
4:43/50

Im
Loi/P

Pneumologue

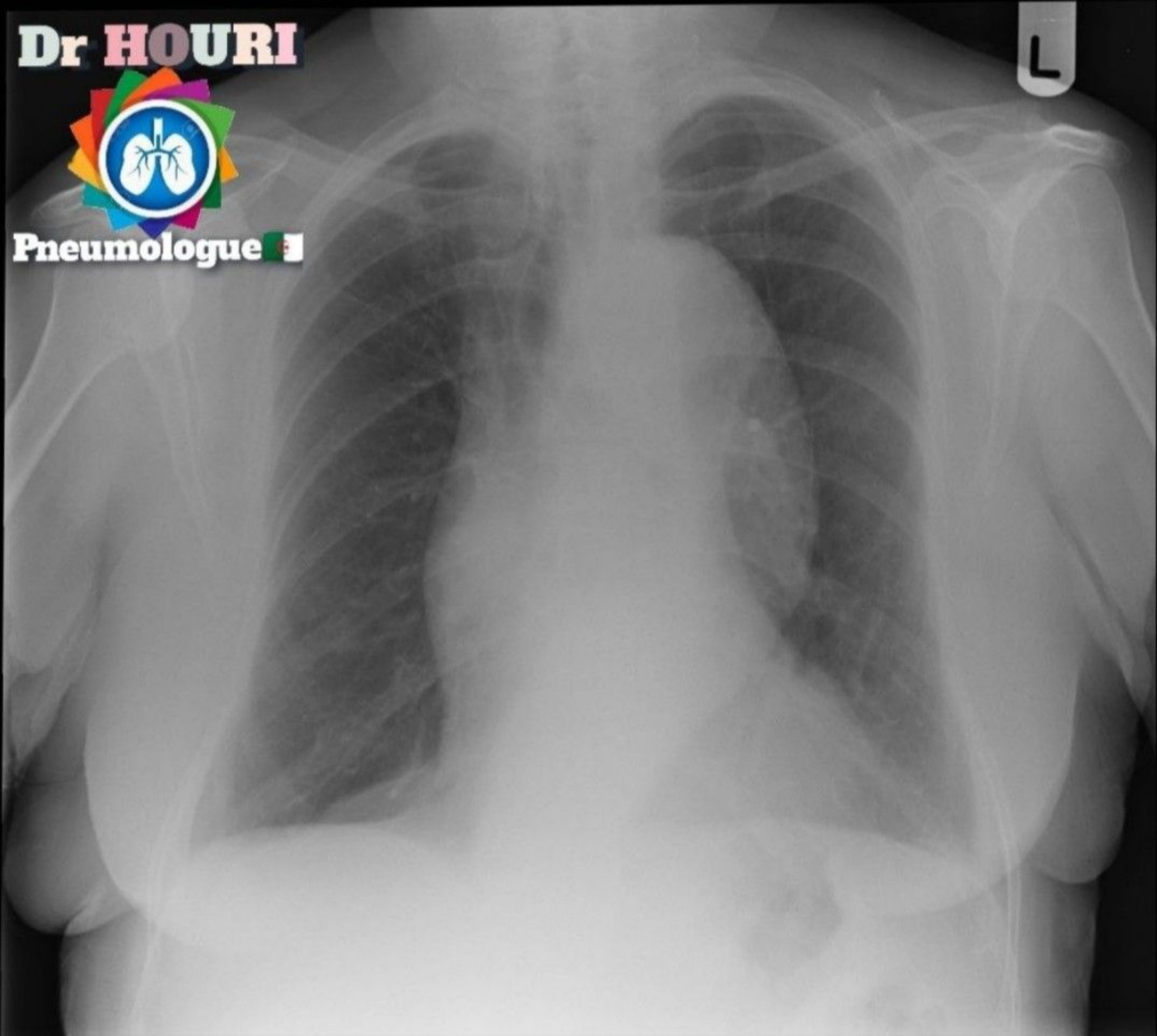
m: 1.00x
096 L:2048 (Auto)

RE
RI JAYADEVA INSTITUTE OF CARDIO
DFOV: 35.2 x 35.2

Dr HOURI



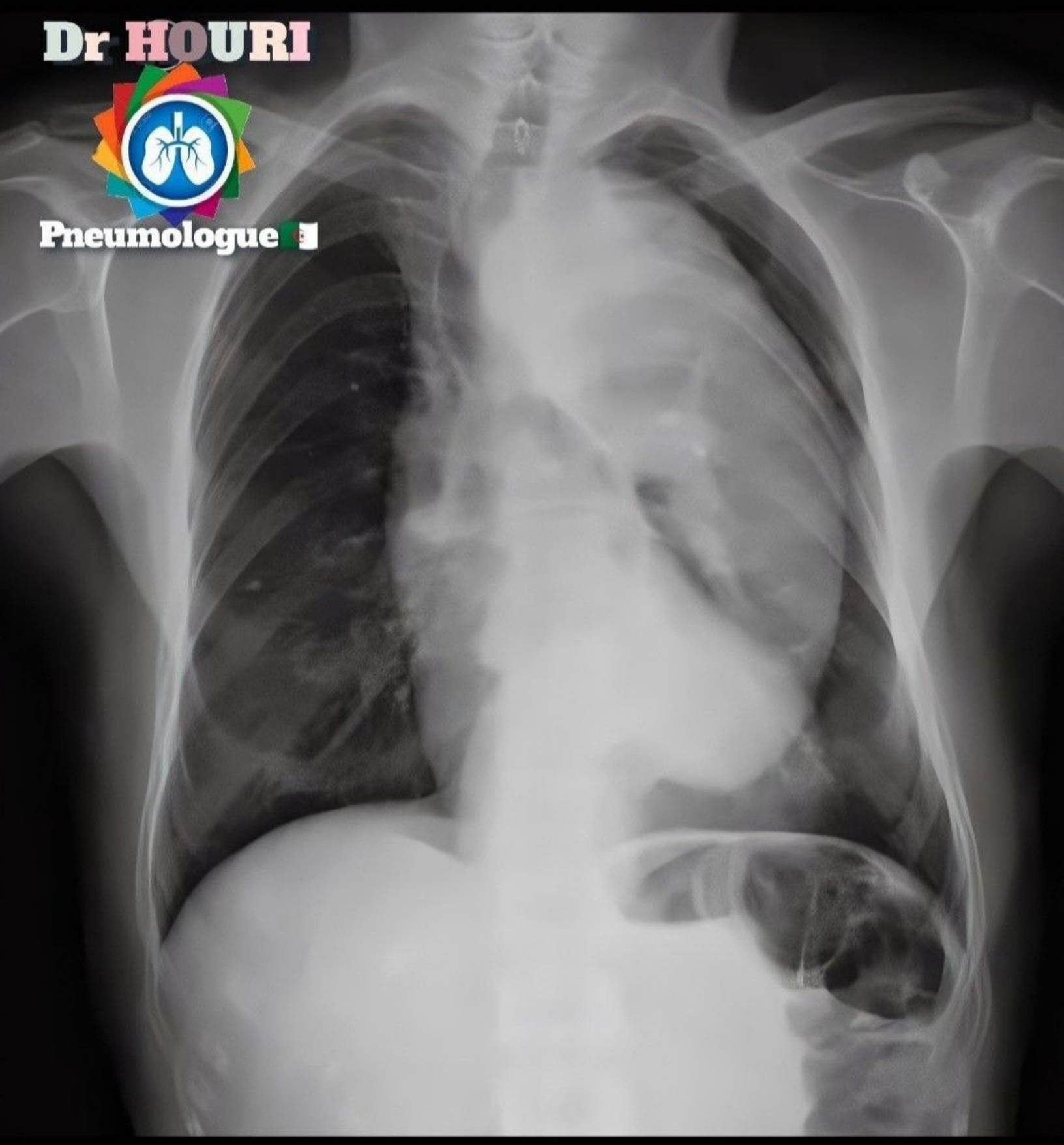
Pneumologue



Dr HOURI



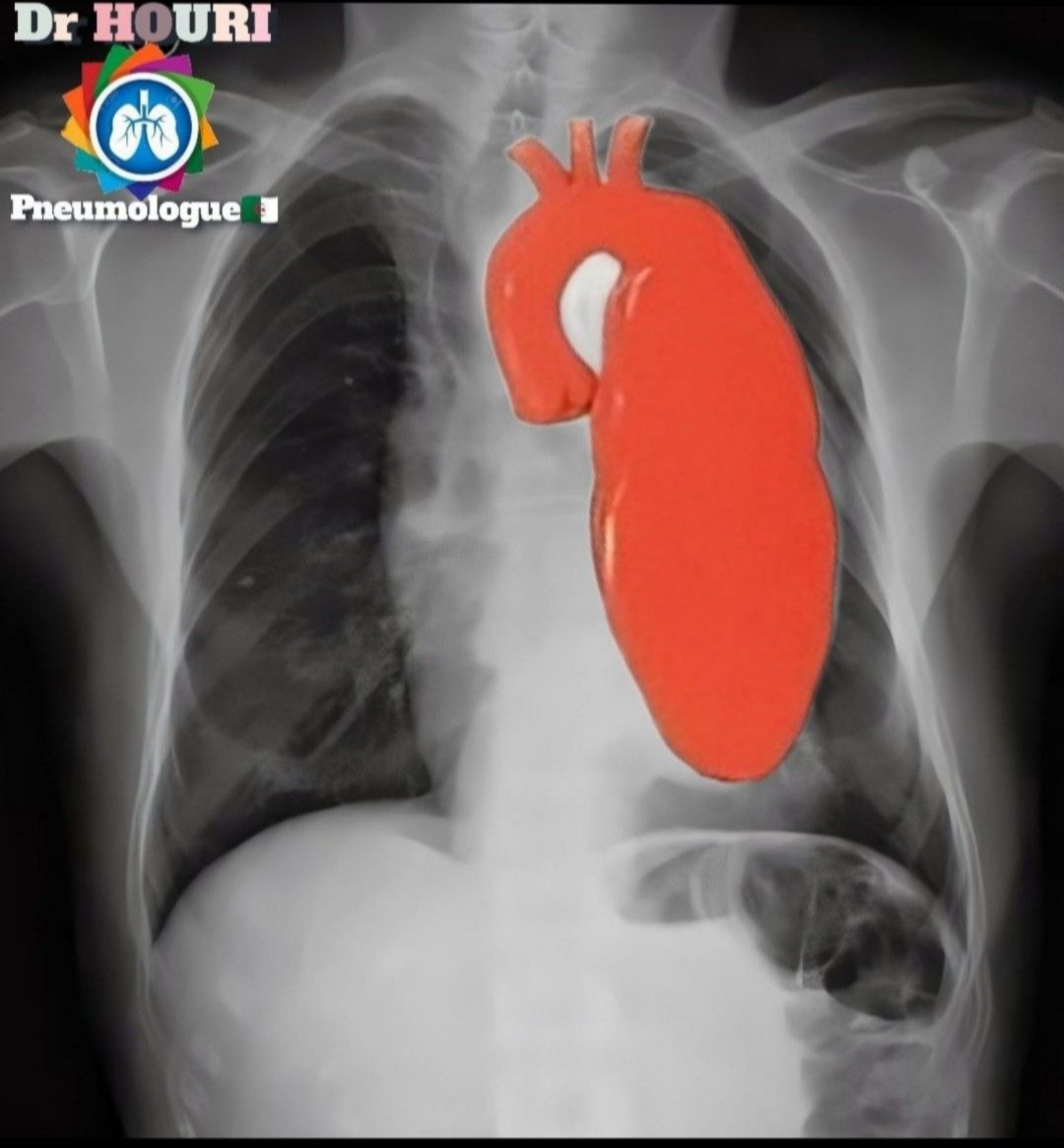
Pneumologue 



Dr HOURI



Pneumologue 



Dr HOURI



Pneumologue

L
KR





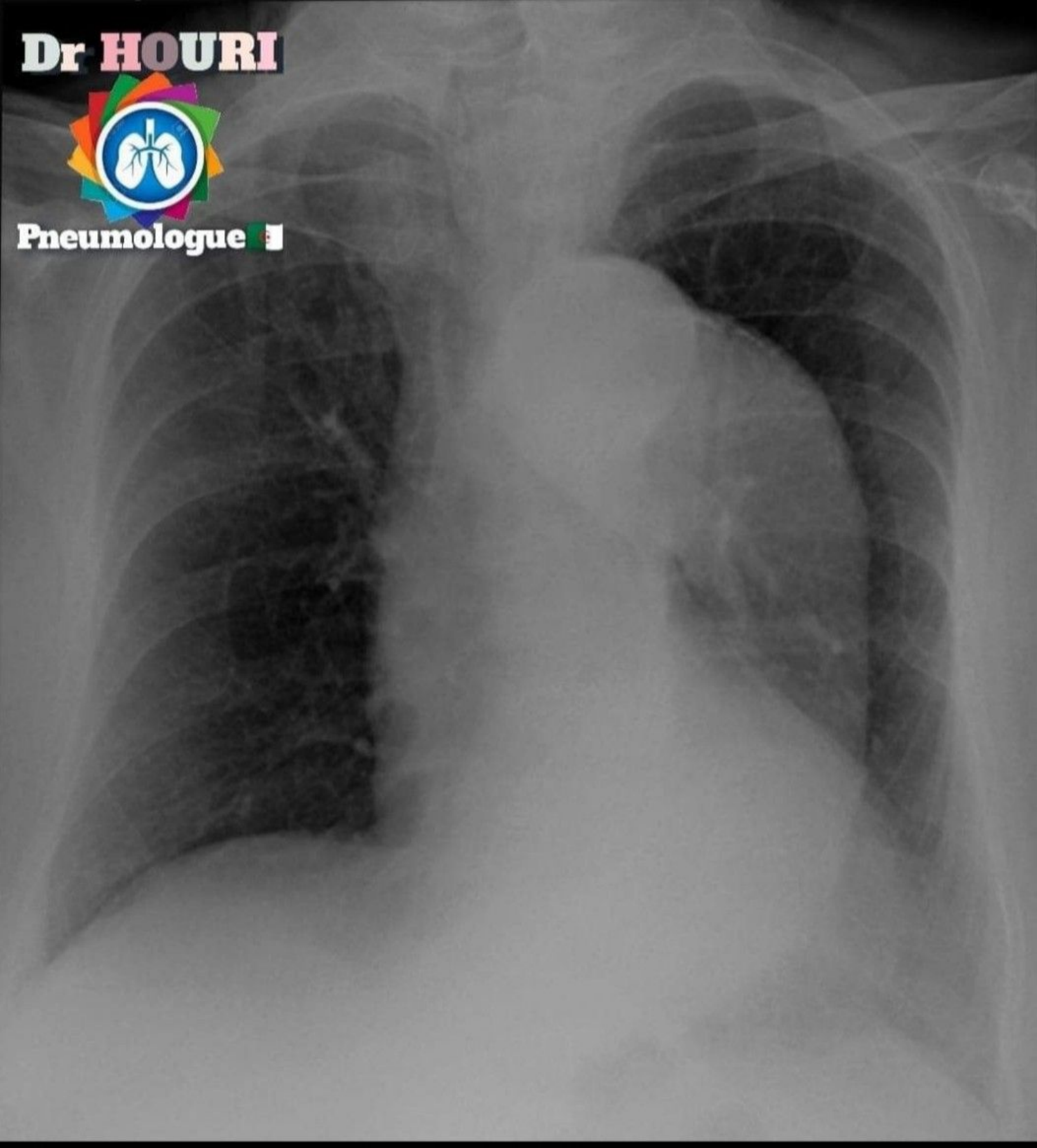
Anévrisme

Aorte

Dr HOURI



Pneumologue 



Dr HOURI



Pneumologue 

**crosse
aortique**

**Anévrisme
de l'aorte
descendante .**

14-DEXTROCARDIE

14-DEXTROCARDIE :

La dextrocardie est une anomalie congénitale dans laquelle le cœur est situé du côté droit du thorax au lieu du côté gauche.

◆ Types principaux

▼ Dextrocardie isolée

Le cœur est à droite, mais les autres organes sont en position normale

▼ Dextrocardie avec situs inversus totalis

Inversion complète des organes (foie à gauche, rate à droite.)

Compatible avec une vie normale

▼ Dextrocardie avec situs ambigu (hétérotaxie)

Organisation anarchique des organes

◆ Diagnostic

✓ Radiographie thoracique

Apex cardiaque à droite

Bulle gastrique souvent déplacée selon le type

✓ ECG

Inversion des dérivations (aspect inhabituel)

Échocardiographie

Examen clé pour rechercher des malformations associées









R

16

